AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 16 · DE · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

DERMATOLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

86	18	13
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · complemento visual del Tomo 16

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 16 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 48

Índice por tipo de imagen 57

Soluciones de la autoevaluación 67

Signos con nombre propio 55

Autoevaluación 58

01 Semiología Cutánea, Acné, Rosácea & Alopecias

16.1 Lesiones elementales

01 Mancha café con leche 4
02 Eritema nudoso 5
03 Púrpura palpable 4
04 Vesículas de herpes simple 6
05 Ampollas tensas (penfigoide) 6
06 Habones 7
07 Pústulas palmares 7
08 Pápulas de molusco contagioso 8
09 Liquenificación 8
10 Úlcera con escara 9

16.2 Acné vulgar

11 Acné comedoniano 9
12 Acné pápulo-pustuloso 10
13 Acné nódulo-quístico 10

16.3 Rosácea

14 Rosácea pápulo-pustulosa 11
15 Rinofima (rosácea fimatosa) 11

16.4 Alopecias

16 Alopecia areata 12
17 Alopecia androgenética: escala de Hamilton-Norwood 12

02 Dermatosis Inflamatorias, Psoriasis & Eccemas

16.5 Psoriasis

18 Psoriasis en placas 13
19 Psoriasis en gotas 13
20 Pitting ungueal 14
21 Fenómeno de Koebner 14
22 Artritis psoriásica 15
23 Psoriasis pustulosa generalizada 15
24 Líquen plano oral erosivo 16

16.6 Dermatitis atópica

25 Eccema herpético de Kaposi 16
26 Dermatitis atópica: eccema con rascado 17
27 Impetiginización de la dermatitis atópica 17

16.7 Seborreica y de contacto

28 Dermatitis de contacto irritativa 18
29 Eccema de contacto alérgico 18
30 Dermatitis seborreica del adulto 19
31 Fototoxicidad 19

16.8 Urticaria y angioedema

32 Urticaria aguda 20
33 Angioedema labial 20

03 Farmacodermias Graves & Enfermedades Ampollares

16.9 SSJ / NET

34 Stevens-Johnson: dianas atípicas 21
35 Necrólisis epidérmica: mucosas 21
36 Necrólisis epidérmica tóxica 22
37 Stevens-Johnson: labios 22
38 Síndrome de piel escaldada estafilocócica 23

16.10 DRESS y toxidermias

39 Exantema morbiliforme (maculopapular) 23
40 DRESS: exantema del tronco 24
41 DRESS: edema facial 24
42 Toxidermia fija 25

Índice por tema · continuación

16.11 Pénfigo y penfigoide

43 IFD de pénfigo vulgar 25
44 Pénfigo vulgar 26
45 Penfigoide ampollar 27
46 Pénfigo vulgar oral 26

16.12 Eritema multiforme y virus

47 Eritema multiforme 28
48 Eritema multiforme: dianas en las manos 28
49 Molusco contagioso 29
50 Test de Tzanck: célula gigante multinucleada 29
51 Herpes zóster diseminado 30
52 Verruga vulgar 30

04 Oncología Cutánea, Lesiones Premalignas & Infecciones Cutáneas

16.13 Melanoma

53 Nevo melanocítico común 31
54 Melanoma nodular 31
55 Melanoma: regla ABCDE 32
56 Melanoma lentiginoso acral subungueal 32

16.14 CBC y CEC

57 Carcinoma basocelular nodular 33
58 Úlcera de Rodent (CBC ulcerado) 33
59 Carcinoma espinocelular 34
60 Carcinoma espinocelular del labio 34

16.15 Lesiones premalignas

61 Nevos displásicos (atípicos) 35
62 Cuerno cutáneo 35
63 Queratosis actínica 36
64 Enfermedad de Bowen 36

16.16 Micosis y ectoparásitos

65 Tiña capitis 37
66 Tiña inguinal (cruris) 37
67 Tiña corporis 38
68 Pitiriasis versicolor 38
69 Escabiosis 39
70 Pitiriasis rosada: placa heráldica 39
71 Tiña pedis interdigital 40

16.17 Tumores benignos y vasculares

72 Queratosis seborreicas 40
73 Quiste epidérmico 41
74 Lipomas múltiples 41
75 Dermatofibroma 42
76 Queloide del lóbulo 42
77 Hemangioma infantil superficial 43
78 Hemangioma infantil mixto 43
79 Hemangioma periocular 44
80 Hemangioma infantil segmentario 44
81 Mancha salmón (nevus simplex) 45
82 Malformación capilar (mancha en vino de Oporto) 45

16.18 Loxoscelismo

83 Araña de rincón (Loxosceles laeta) 46
84 Loxoscelismo cutáneo: placa livedoide 46
85 Loxoscelismo: escara negra 47
86 Loxoscelismo: úlcera de fondo fibrinoso 47

01 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 622

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lesión plana: cambio de color sin relieve ni depresión
2. Mayor de 1 cm: es mancha, no mácula

DIAGNÓSTICO

Mancha café con leche

Mancha = lesión plana mayor de 1 cm: solo cambio de color, sin relieve.

CONDUCTA INICIAL

Describir la lesión elemental: el corte de 1 cm separa mácula de mancha.

6.01.3.003 **Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Mácula (< 1 cm, p. ej. efélide) y vitíligo (mancha blanco tiza, bordes netos, sin escama).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 6** Tema 16.1

Clase 16.1 en video

03 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 8

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pápulas purpúricas que se palpan
2. Varias lesiones en la pierna

DIAGNÓSTICO

Púrpura palpable

No desaparece a la vitropresión: es púrpura; palpable en las piernas = vasculitis.

CONDUCTA INICIAL

Buscar la enfermedad de fondo (vasculitis; Schönlein-Henoch en niños) y tratar la causa.

6.01.3.003 **Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Eritema (sí desaparece a la vitropresión) y vasculitis urticariana (habón fijo que deja púrpura).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 6** Tema 16.1

Clase 16.1 en video

02 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulos eritematosos mal delimitados en la cara anterior de la pierna
2. Bilaterales: también en la otra pierna
- Se palpan más de lo que se ven: lesión de la hipodermis

CONDUCTA INICIAL

Reposo con piernas elevadas, AINE y buscar la causa: hemograma, VHS, ASO, Rx de tórax, PPD y test de embarazo.

6.01.1.009 Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

DIAGNÓSTICO

Eritema nudoso

Paniculitis septal: nódulos pretibiales rojos y dolorosos que no se ulceran ni dejan cicatriz.

SE CONFUNDE CON…

Eritema indurado de Bazin: pantorrillas, se ulcera, deja cicatriz y exige biopsia (TBC).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA p. 7 Tema 16.1

Clase 16.1 en video

04 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA

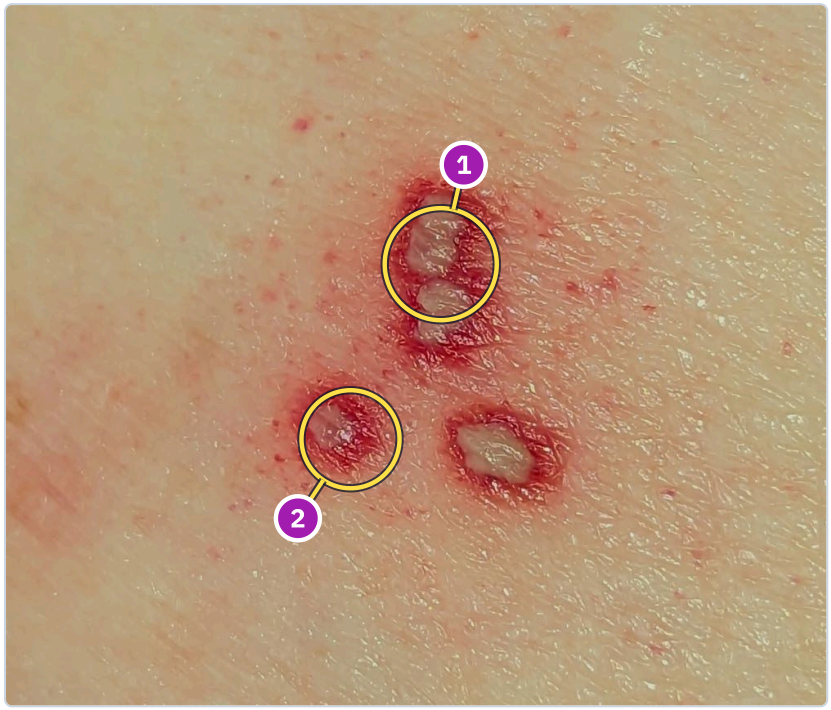


Imagen: Manual AMIR Dermatología

QUÉ TIENES QUE VER

1. Vesícula: contenido líquido, menor de 0,5 cm
2. Agrupadas en racimo sobre base eritematosa

DIAGNÓSTICO

Vesículas de herpes simple

Vesícula: colección líquida menor de 0,5 cm; en el herpes, agrupadas en racimo.

CONDUCTA INICIAL

Herpes simple: aciclovir oral; supresión si hay 6 o más episodios al año.

`6.01.1.031` **Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Ampolla (líquida, mayor de 0,5–1 cm) y pústula (purulenta desde el inicio).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 6** Tema 16.1

Clase 16.1 en video

05 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 72

QUÉ TIENES QUE VER

1. Ampollas de contenido seroso, mayores de 0,5–1 cm
2. Varias ampollas íntegras en la extremidad

DIAGNÓSTICO

Ampollas tensas (penfigoide)

Ampolla: colección líquida mayor de 0,5–1 cm; tensa y de pared gruesa en el penfigoide.

CONDUCTA INICIAL

Ampolla tensa en un anciano con prurito: sospechar penfigoide, biopsia con IFD y clobetasol tópico.

`6.01.2.010` **Pénfigo y penfigoide**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vesícula (menor de 0,5 cm) y ampolla flácida del pénfigo (se rompe fácil, Nikolsky positivo).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 6** Tema 16.1

Clase 16.1 en video

06 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA

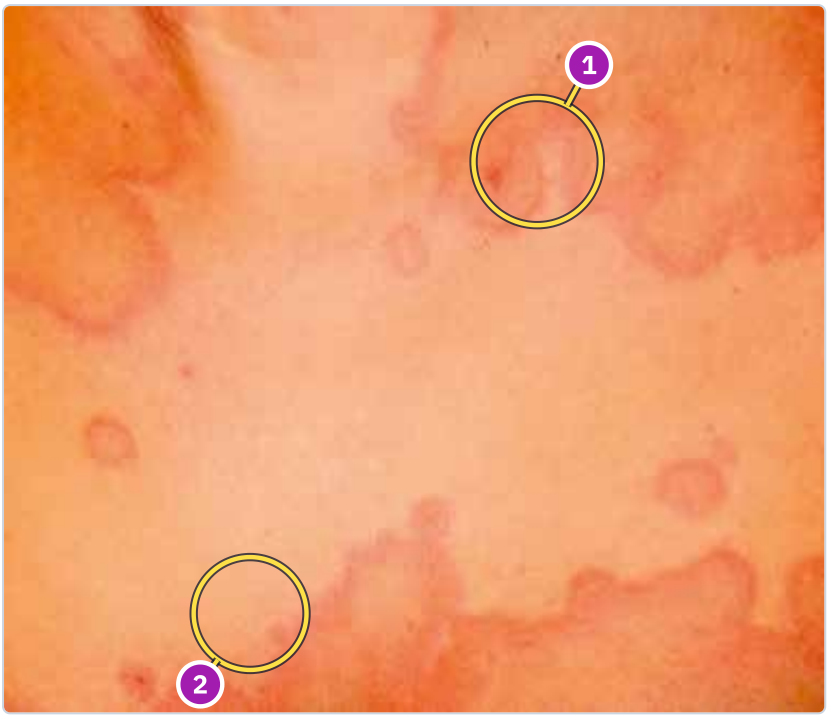


Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 49

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa edematosa sobreelevada, rosada o blanquecina
2. Halo eritematoso de borde geográfico

DIAGNÓSTICO

Habones

Habón: placa edematosa con halo eritematoso, EVANESCENTE: dura menos de 24 horas.

CONDUCTA INICIAL

Antihistamínico H1 de 2.ª generación; preguntar siempre cuánto dura cada lesión.

6.01.1.030 **Urticaria aguda**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Vasculitis urticariana: lesión fija más de 24–48 h, arde y deja púrpura (biopsia).

PREGUNTA REAL

Agosto 2021 · P34 «Un niño de 4 años presenta aparición de ronchas evanescentes en el tronco y extremidades, desde hace 4 días. Además, desde hace algunos días…» → **Indicar antihistamínicos orales**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 6 Tema 16.1

Clase 16.1 en video

07 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA

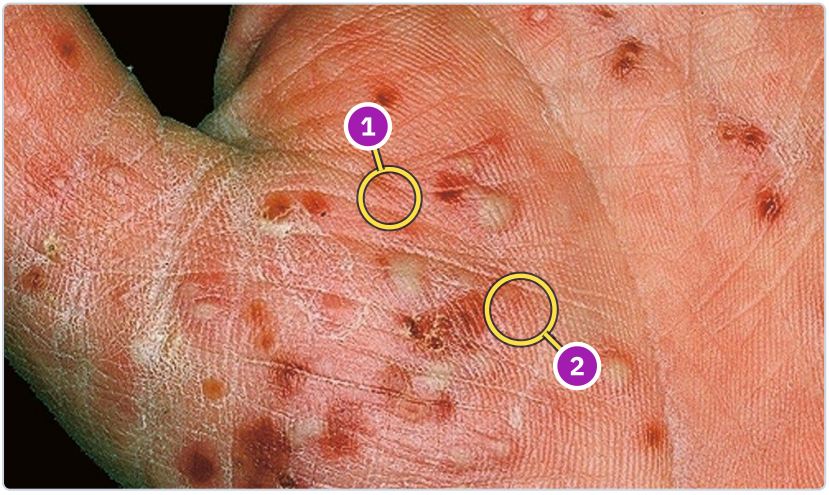


Imagen: Manual AMIR Dermatología

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pústula de contenido purulento
2. Varias lesiones en la palma

DIAGNÓSTICO

Pústulas palmares

Pústula: colección superficial de contenido purulento desde su inicio.

CONDUCTA INICIAL

Reconocer la lesión primaria y buscar la causa (p. ej. acné pustuloso, foliculitis).

Lesión elemental: sin código propio · ver códigos del tema 16.1

SE CONFUNDE CON…

Vesícula: contenido seroso o hemático, no purulento.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P55 «Un paciente de 21 años consulta por aparición de lesiones cutáneas en la zona glútea de 6 días de evolución, consistentes en pápulas y pústulas,…» → **Flucloxacilina**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 6 Tema 16.1

Clase 16.1 en video

08 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA

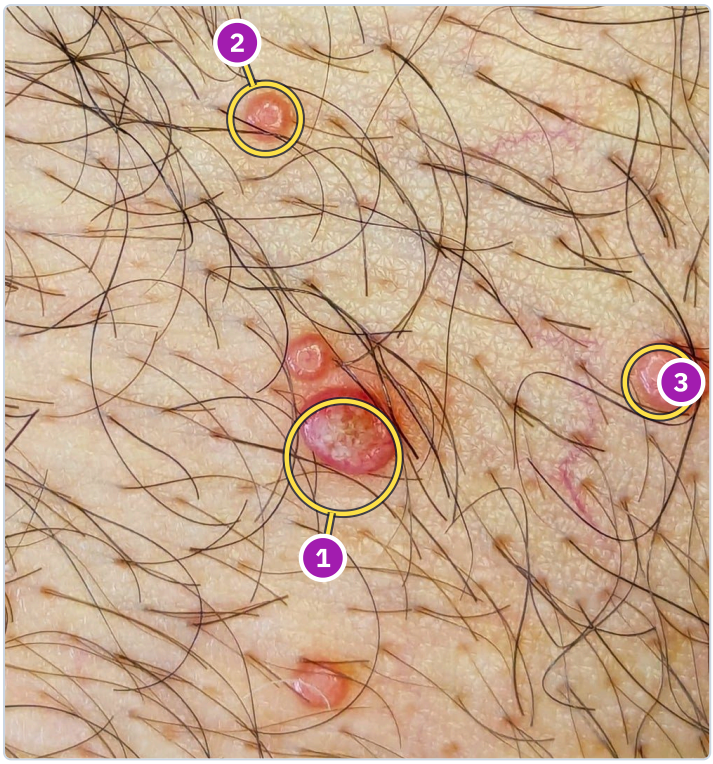


Imagen: Manual AMIR Dermatología

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pápula sólida, menor de 1 cm
2. Superficie perlada con depresión central
3. Otras pápulas aisladas

DIAGNÓSTICO

Pápulas de molusco contagioso

Pápula: elevación sólida menor de 1 cm; la del molusco es perlada y umbilicada.

CONDUCTA INICIAL

Molusco: autolimitado; curetaje o crioterapia; evitar el rascado y compartir toallas.

6.01.1.031 **Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Placa: sólida, mayor de 1 cm, en meseta (confluencia de pápulas).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 6** Tema 16.1

Clase 16.1 en video

09 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed.

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cuadrícula normal de la piel acentuada
2. Excoriaciones lineales por rascado

DIAGNÓSTICO

Liquenificación

Engrosamiento con cuadrícula cutánea exagerada por rascado crónico repetitivo.

CONDUCTA INICIAL

Cortar el rascado y tratar la dermatosis de fondo (p. ej. dermatitis atópica del adulto).

6.01.1.004 **Dermatitis atópica**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Eccema agudo (exudativo, con costras) y placa de psoriasis (escama nacarada).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 6** Tema 16.1

Clase 16.1 en video

10 TEMA 16.1 · LESIONES ELEMENTALES

FOTO CLÍNICA

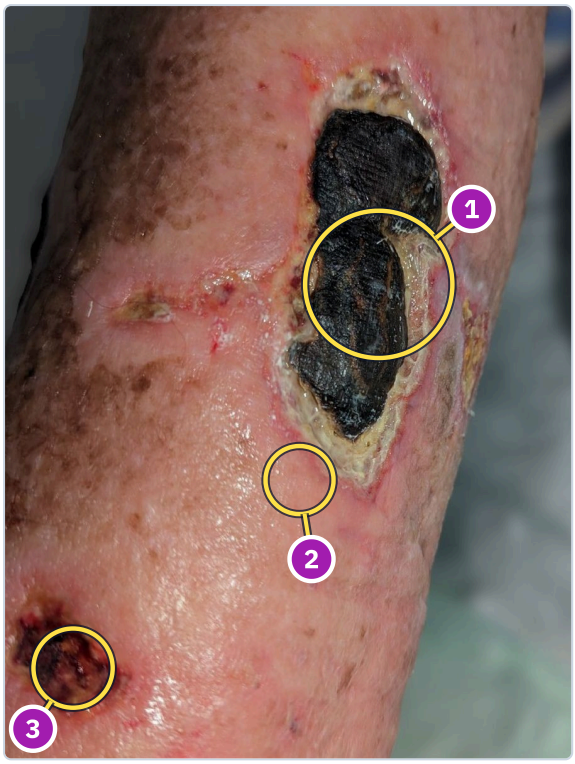


Imagen: Manual AMIR Dermatología

QUÉ TIENES QUE VER

1. Escara negra y seca
2. Bien delimitada de la piel sana vecina
3. Otra lesión ulcerada más abajo

DIAGNÓSTICO

Úlcera con escara

Escara: tejido necrótico negro, seco y delimitado; la úlcera llega a la dermis y siempre deja cicatriz.

CONDUCTA INICIAL

Úlcera = dermis comprometida: buscar la causa (úlcera venosa, por presión, loxoscelismo).

Lesión elemental: sin código propio · ver códigos del tema 16.1

SE CONFUNDE CON…

Erosión: compromete solo la epidermis y cura SIN cicatriz.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 6** Tema 16.1

Clase 16.1 en video

11 TEMA 16.2 · ACNÉ VULGAR

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 66

QUÉ TIENES QUE VER

1. Comedones cerrados («puntos blancos»)
2. Múltiples, en la frente

DIAGNÓSTICO

Acné comedoniano

El comedón es la lesión elemental obligatoria que define al acné.

CONDUCTA INICIAL

Retinoide tópico de noche (adapaleno 0,1%) ± peróxido de benzoilo.

`6.01.1.001` Acné — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`2.01.1.104` Acné — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Rosácea: eritema con pápulas y pústulas, NUNCA comedones.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 10** Tema 16.2

Clase 16.2 en video

12 TEMA 16.2 · ACNÉ VULGAR

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 732

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pápulas eritematosas inflamatorias
2. Pústulas superficiales

DIAGNÓSTICO

Acné pápulo-pustuloso

Pápulas eritematosas inflamatorias y pústulas superficiales sobre el comedón.

CONDUCTA INICIAL

Leve: peróxido de benzoilo + retinoide ± clindamicina; moderado: doxiciclina oral 8–12 semanas.

6.01.1.001 Acné — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

2.01.1.104 Acné — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Rosácea pápulo-pustulosa: sobre eritema centrofacial y SIN comedones.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 10** Tema 16.2

Clase 16.2 en video

13 TEMA 16.2 · ACNÉ VULGAR

FOTO CLÍNICA

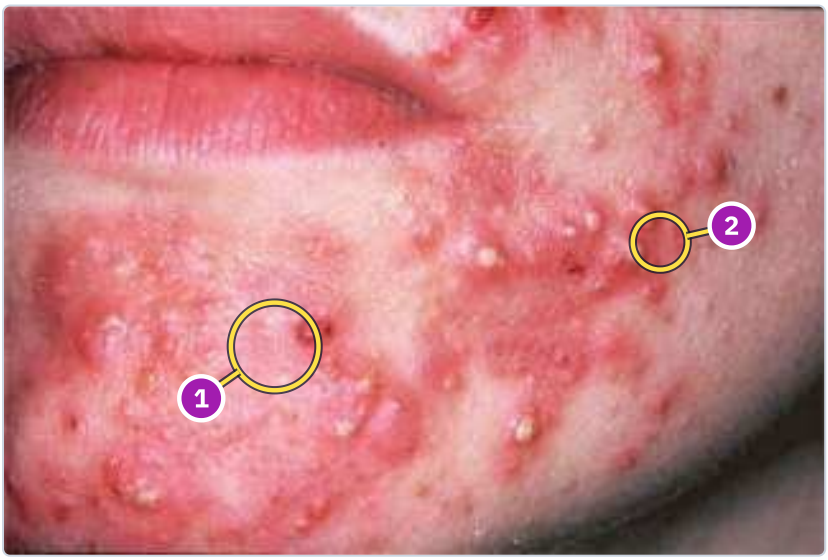


Imagen: Atlas of Dermatopathology, p. 354

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulos profundos inflamatorios
2. Pústulas sobre los nódulos

DIAGNÓSTICO

Acné nódulo-quístico

Nódulos profundos y dolorosos con alto riesgo de cicatriz: indicación de isotretinoína.

CONDUCTA INICIAL

Isotretinoína oral: doble anticoncepción, test de embarazo y control lipídico y hepático.

6.01.1.001 Acné — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Acné pápulo-pustuloso moderado: se trata con doxiciclina oral.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 10** Tema 16.2

Clase 16.2 en video

14 TEMA 16.3 · ROSÁCEA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 84

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pápulas y pústulas en la mejilla
2. Eritema de base en nariz y mejilla
- No hay comedones: si los hubiera, sería acné

DIAGNÓSTICO

Rosácea pápulo-pustulosa

Pápulas y pústulas centrofaciales sobre eritema persistente, SIN comedones.

CONDUCTA INICIAL

Metronidazol o ivermectina tópica; doxiciclina oral si es moderada a severa. Nunca corticoide tópico.

6.01.1.026 Rosácea

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Acné vulgar: siempre tiene comedones.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P61** «Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con…» → **Rosácea**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 14** Tema 16.3

Clase 16.3 en video

15 TEMA 16.3 · ROSÁCEA

FOTO CLÍNICA

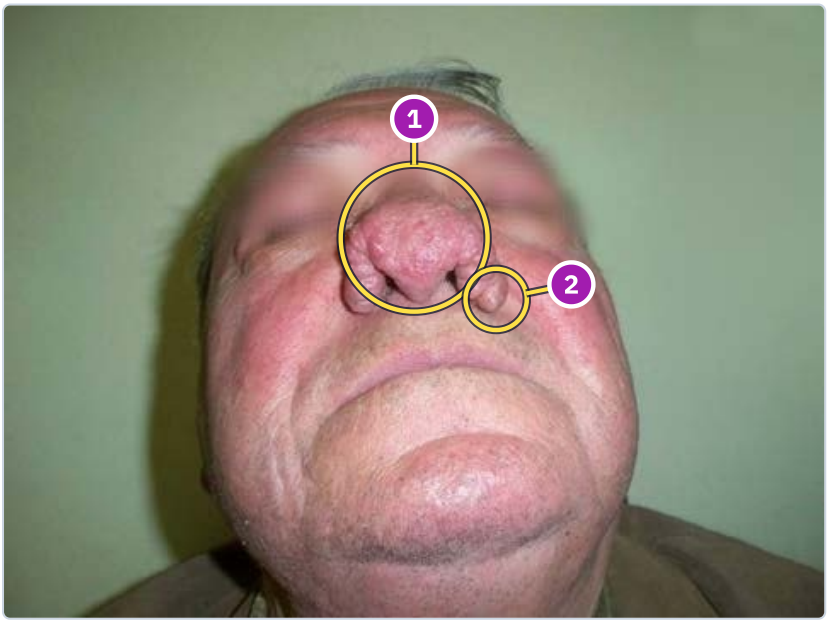


Imagen: Manual AMIR Otorrinolaringología, p. 41

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nariz globulosa, bulbosa y deformada
2. Nódulos lobulados en las alas nasales

DIAGNÓSTICO

Rinofima (rosácea fimatosa)

Nariz bulbosa por hipertrofia sebácea y fibrosis; típica en varones.

CONDUCTA INICIAL

No responde a fármacos: resección quirúrgica, electrocirugía o láser de CO_2.

6.01.1.026 Rosácea

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Rosácea pápulo-pustulosa: esa sí responde al tratamiento médico.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P61** «Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con…» → **Rosácea**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 14** Tema 16.3

Clase 16.3 en video

16 TEMA 16.4 · ALOPECIAS

FOTO CLÍNICA

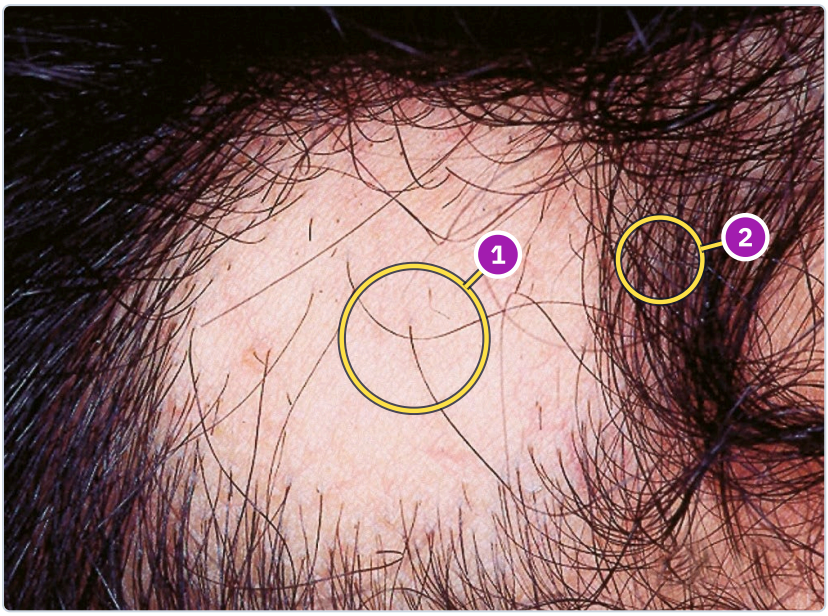


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 88

QUÉ TIENES QUE VER

1. Piel lisa, sin escama ni eritema
2. Borde de la placa: ahí se buscan los pelos «en signo de exclamación»

DIAGNÓSTICO

Alopecia areata

Placa alopécica redonda, lisa, de piel normal: autoinmune y no cicatricial.

CONDUCTA INICIAL

Corticoide intralesional (triamcinolona) o tópico de alta potencia.

6.01.1.002 Alopecías

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tiña capitis (escama y pelos rotos, en niños) y alopecia cicatricial (sin orificios foliculares).

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P151 «Un paciente de 19 años consulta por caída de cabello en la zona occipital, que inició hace 2 semanas. Al examen físico, se aprecia una zona sin…» → **Alopecia areata**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 18** Tema 16.4

Clase 16.4 en video

17 TEMA 16.4 · ALOPECIAS

ESQUEMA

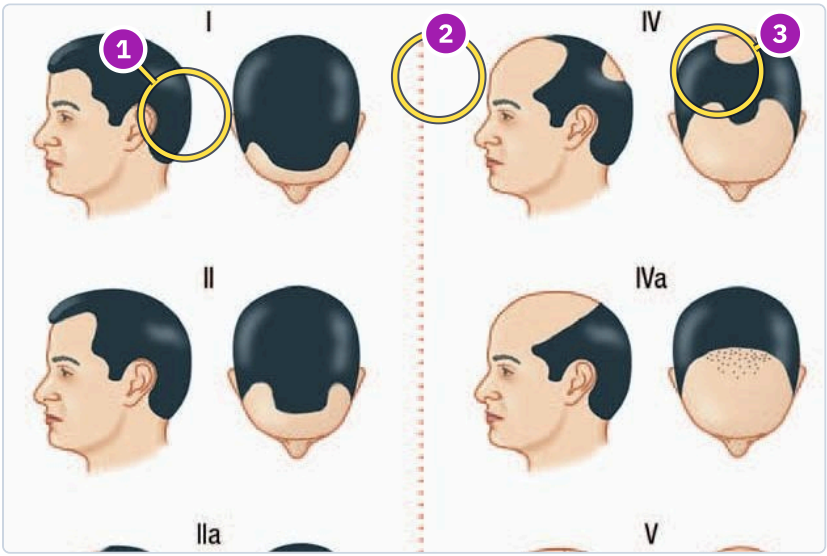


Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 805

QUÉ TIENES QUE VER

1. Retroceso frontotemporal («entradas»)
2. Progresa hacia el vértice
3. Pérdida de la coronilla

DIAGNÓSTICO

Alopecia androgenética: escala de Hamilton-Norwood

Miniaturización folicular por dihidrotestosterona: entradas y luego vértice.

CONDUCTA INICIAL

Minoxidil tópico 5% + finasteride oral 1 mg (contraindicado en mujer fértil).

6.01.1.002 Alopecías

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Patrón femenino (Ludwig): raya central ensanchada, respeta la línea frontal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 18** Tema 16.4

Clase 16.4 en video

18 TEMA 16.5 · PSORIASIS

FOTO CLÍNICA

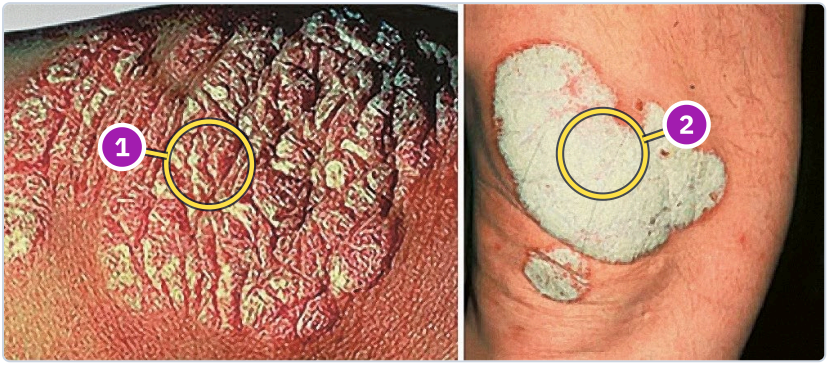


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 39

QUÉ TIENES QUE VER

1. Escamas gruesas blanco-nacaradas, no grasosas
2. Placa bien delimitada en superficie de extensión
- Raspado de Brocq: bujía → membrana despegable → Auspitz (rocío sangrante)

DIAGNÓSTICO

Psoriasis en placas

Placas eritematosas bien delimitadas con escama gruesa blanco-nacarada en superficies de extensión.

CONDUCTA INICIAL

Leve: corticoide potente + calcipotriol. NUNCA corticoides sistémicos (rebote pustuloso).

6.01.1.024 Psoriasis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Eccema: pliegues flexurales, prurito intenso y liquenificación.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P120 «Mujer de 35 años con placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de escamas plateadas en rodillas y codos, con fenómeno de Auspitz positivo....» → **Psoriasis en placas**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 27** Tema 16.5

Clase 16.5 en video

19 TEMA 16.5 · PSORIASIS

FOTO CLÍNICA

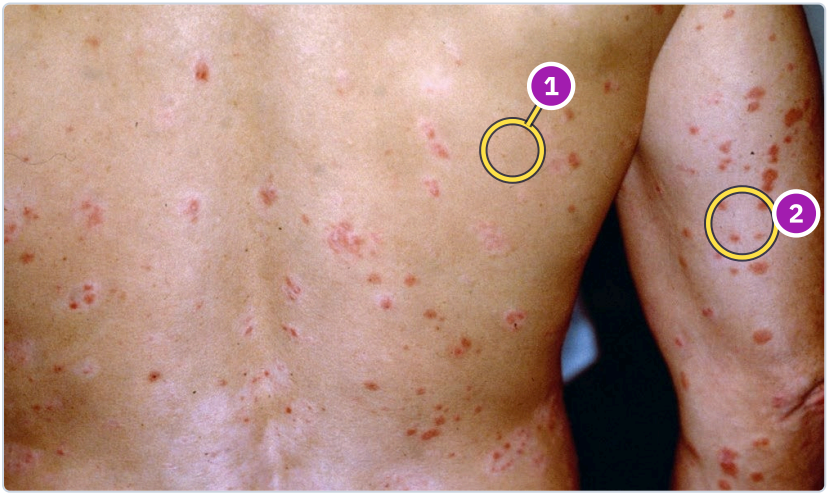


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 40

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pápulas pequeñas descamativas en el tronco
2. Erupción generalizada, también en el brazo

DIAGNÓSTICO

Psoriasis en gotas

Pápulas milimétricas descamativas «en gotas de lluvia» 1–2 semanas tras una faringoamigdalitis.

CONDUCTA INICIAL

Antibiótico (amoxicilina o penicilina) + fototerapia UVB; excelente pronóstico.

6.01.1.024 Psoriasis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Pitiriasis rosada: medallón previo y distribución «en árbol de Navidad».

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 26** Tema 16.5

Clase 16.5 en video

20 TEMA 16.5 · PSORIASIS

FOTO CLÍNICA

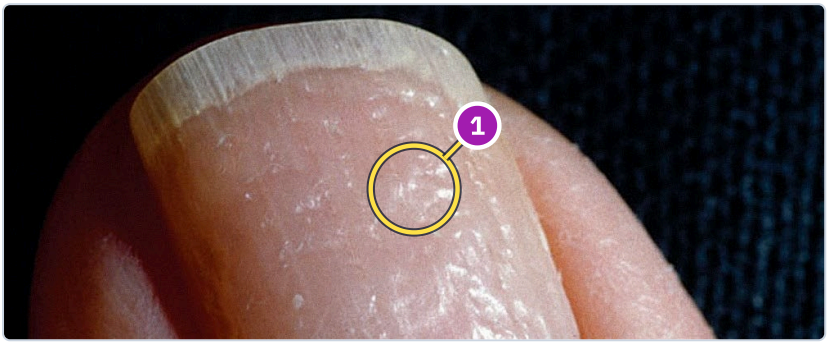


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 40

QUÉ TIENES QUE VER

1. Depresiones puntiformes en la lámina ungueal
- La psoriasis ungueal se asocia a artritis psoriásica

DIAGNÓSTICO

Pitting ungueal

Piqueteado en dedal: pequeñas depresiones cupuliformes de la lámina (psoriasis ungueal).

CONDUCTA INICIAL

Buscar artritis psoriásica: rigidez matinal de más de 30 minutos, dactilitis, entesitis.

`6.01.1.024` **Psoriasis**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

`1.11.1.001` **Artritis psoriática**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Onicomicosis: se confirma con KOH antes de un tratamiento oral.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 27** Tema 16.5

Clase 16.5 en video

21 TEMA 16.5 · PSORIASIS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 10

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placas alineadas sobre una cicatriz
2. Otras placas psoriásicas vecinas

DIAGNÓSTICO

Fenómeno de Koebner

Lesiones psoriásicas típicas sobre piel sana traumatizada (cicatriz, roce, rascado).

CONDUCTA INICIAL

El trauma local es desencadenante; tratamiento tópico: corticoide potente + calcipotriol.

`6.01.1.024` **Psoriasis**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

El Koebner también aparece en vitíligo, líquen plano y verrugas planas.

PREGUNTA REAL — **Julio 2015 · P88** «Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El…» → **Psoriasis vulgar**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 27** Tema 16.5

Clase 16.5 en video

22 TEMA 16.5 · PSORIASIS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Reumatología, p. 81

QUÉ TIENES QUE VER

1. Interfalángica distal comprometida
2. Uña distrófica

DIAGNÓSTICO

Artritis psoriásica

Compromiso de interfalángicas distales asociado a psoriasis ungueal; factor reumatoide negativo.

CONDUCTA INICIAL

AINE y derivar precozmente a reumatología; nunca corticoides sistémicos.

`1.11.1.001` **Artritis psoriática**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Artritis reumatoide: la psoriásica tiene FR y anti-CCP negativos.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P29 «Una paciente de 42 años presenta artritis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos, con afectaciónreciente de...» → **Psoriática**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 26** Tema 16.5

Clase 16.5 en video

23 TEMA 16.5 · PSORIASIS

FOTO CLÍNICA

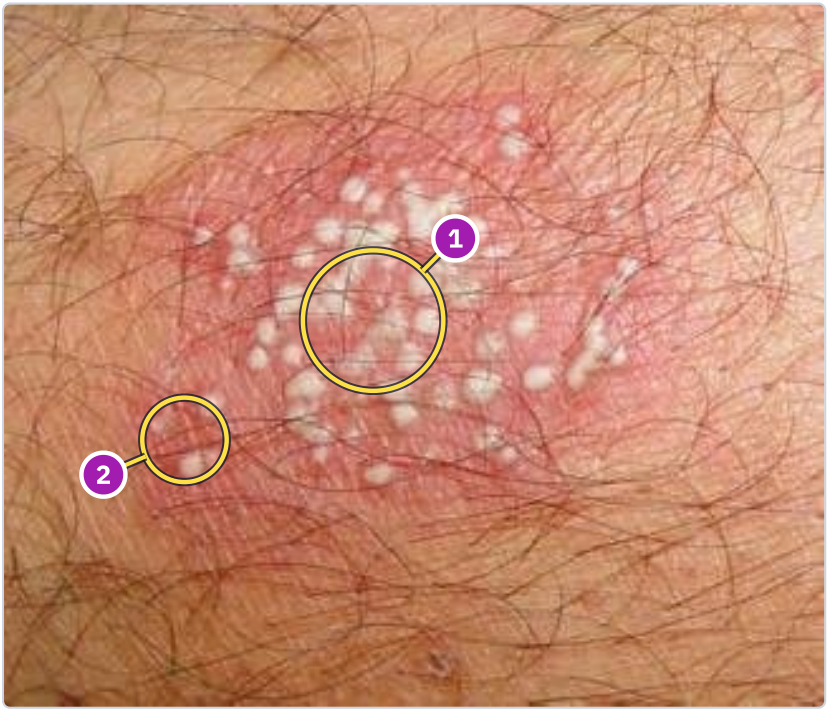


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pústulas estériles agrupadas
2. Base eritematosa

DIAGNÓSTICO

Psoriasis pustulosa generalizada

Pústulas estériles confluentes sobre eritema, con fiebre alta: forma grave potencialmente letal.

CONDUCTA INICIAL

Hospitalización urgente; acitretina o infliximab. Gatillante clásico: suspender corticoides orales.

`6.01.1.024` **Psoriasis**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

`6.01.2.004` **Eritrodermia**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Eritrodermia psoriásica: eritema y descamación de más del 90% de la piel.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 26** Tema 16.5

Clase 16.5 en video

24 TEMA 16.5 · PSORIASIS

FOTO CLÍNICA

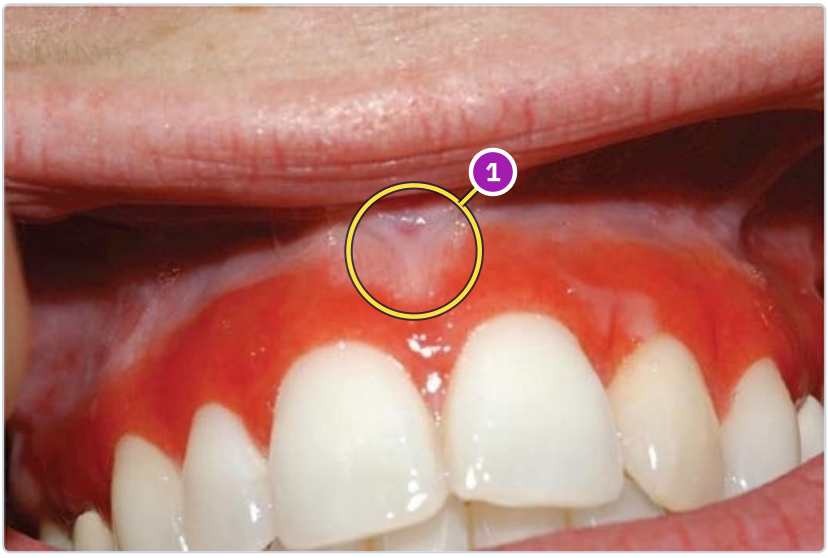


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 274

QUÉ TIENES QUE VER

1. Encía eritematosa y erosionada

DIAGNÓSTICO

Líquen plano oral erosivo

Encía eritematosa y erosionada; el líquen plano se resume en las «seis P».

CONDUCTA INICIAL

Líquen oral erosivo: derivar (riesgo de carcinoma espinocelular cercano al 1%); pedir serología de hepatitis C.

6.01.1.015 Líquen plano — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pénfigo vulgar oral: erosiones dolorosas que preceden a la piel.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 28** Tema 16.5

Clase 16.5 en video

25 TEMA 16.6 · DERMATITIS ATÓPICA

FOTO CLÍNICA

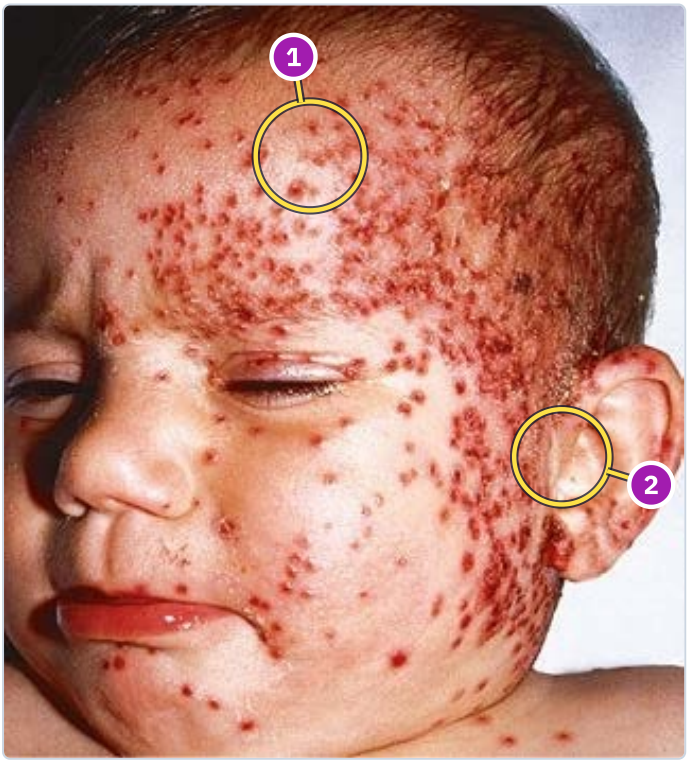


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 1818

QUÉ TIENES QUE VER

1. Erosiones «en sacabocado» agrupadas
2. Lesiones diseminadas por la cara y la oreja

DIAGNÓSTICO

Eccema herpético de Kaposi

Herpes simple diseminado sobre piel atópica: vesículas umbilicadas, erosiones y fiebre. Emergencia.

CONDUCTA INICIAL

Aciclovir endovenoso urgente y hospitalizar.

6.01.1.004 Dermatitis atópica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

2.01.1.107 Dermatitis atópica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Impetiginización: costras melicéricas amarillentas (S. aureus).

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 33** Tema 16.6

Clase 16.6 en video

26 TEMA 16.6 · DERMATITIS ATÓPICA

FOTO CLÍNICA

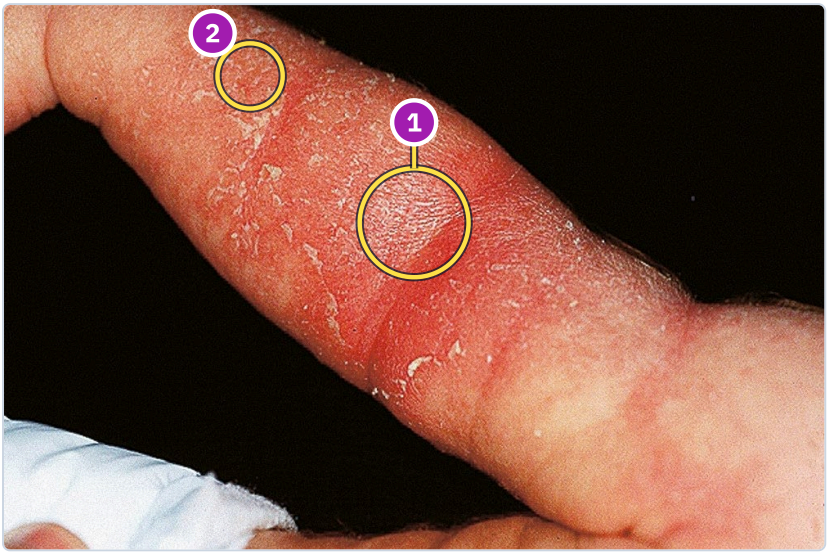


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 91

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa eritematosa con descamación
2. Piel seca con escamas finas (xerosis)

DIAGNÓSTICO

Dermatitis atópica: eccema con rascado

El prurito intenso es el criterio cardinal; en niños mayores y adultos, pliegues flexurales.

CONDUCTA INICIAL

Emolientes diarios («soak and seal») + corticoide tópico según la zona en el brote.

6.01.1.004	Dermatitis atópica	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar
2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Dermatitis de contacto: relacionada con el área de contacto; prueba del parche.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P79 «Una niña de 4 años presenta lesiones cutáneas recurrentes de 2 años de evolución, caracterizadas por pápulas pruriginosas que aparecen en los…» → **Derma22s atópica**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 31** Tema 16.6

Clase 16.6 en video

27 TEMA 16.6 · DERMATITIS ATÓPICA

FOTO CLÍNICA

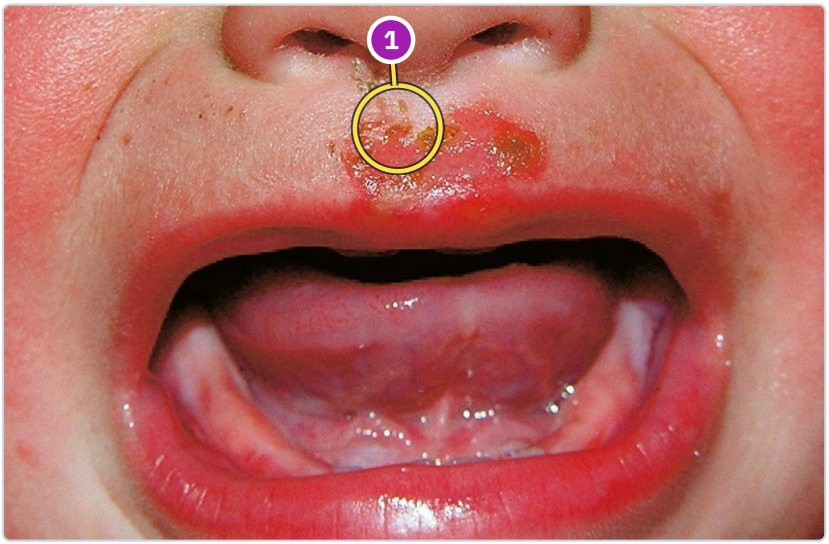


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 55

QUÉ TIENES QUE VER

1. Costras melicéricas amarillentas

DIAGNÓSTICO

Impetiginización de la dermatitis atópica

Sobreinfección por S. aureus: costras melicéricas amarillentas.

CONDUCTA INICIAL

Antibiótico tópico (mupirocina) u oral (cefadroxilo).

2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Eccema herpético de Kaposi: vesículas umbilicadas y fiebre (aciclovir EV).

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P111 «Niño de 7 años con tres lesiones eritematosas con costra melicérica en el abdomen, pruriginosas, sin fiebre. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?» → **Mupirocina tópica al 2%**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 31** Tema 16.6

Clase 16.6 en video

28 TEMA 16.7 · SEBORREICA Y DE CONTACTO

FOTO CLÍNICA

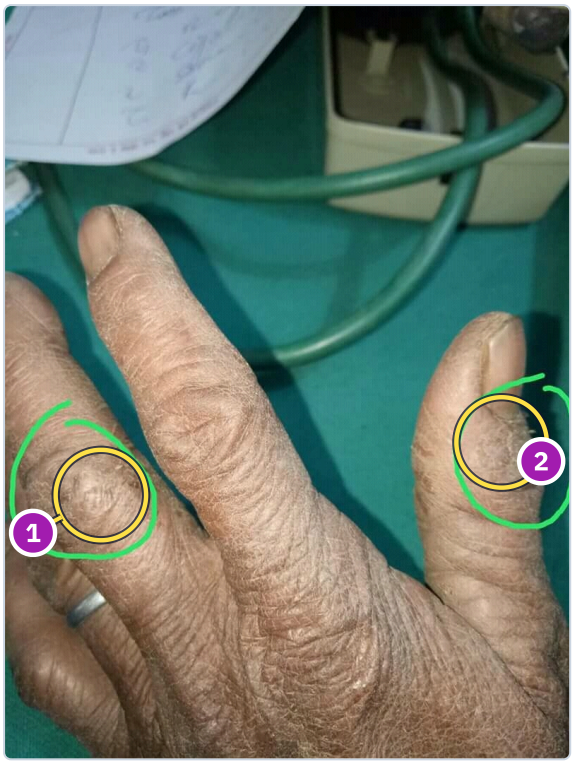


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 · Los círculos verdes vienen en la foto original.

QUÉ TIENES QUE VER

1. Piel seca, agrietada y fisurada
2. Confinada a la zona de contacto

DIAGNÓSTICO

Dermatitis de contacto irritativa

Daño tóxico directo, no inmune (80%): ardor, piel seca y fisurada confinada al contacto.

CONDUCTA INICIAL

Retirar el irritante, guantes con forro de algodón y cremas barrera. Parche negativo.

6.01.1.007 Dermitis de contacto — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Contacto alérgica: prurito intenso, vesículas que sobrepasan el contacto, parche positivo.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA p. 35 Tema 16.7

Clase 16.7 en video

29 TEMA 16.7 · SEBORREICA Y DE CONTACTO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 43

QUÉ TIENES QUE VER

1. Eccema descamativo en el dorso de la mano
- Alérgeno más frecuente: níquel (bisutería, hebillas, botones)

DIAGNÓSTICO

Eccema de contacto alérgico

Hipersensibilidad tipo IV: eccema muy pruriginoso que sobrepasa el área de contacto.

CONDUCTA INICIAL

Evitar el alérgeno + corticoide tópico de mediana o alta potencia 1–2 semanas; parche a las 48 y 96 h.

6.01.1.007 Dermitis de contacto — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

6.01.4.005 Patch test — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Contacto irritativa: ardor, confinada al contacto, parche negativo.

PREGUNTA REAL — **Julio 2016 · P144** «Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una…» → **Dermatitis de contacto alérgica**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 35 Tema 16.7

Clase 16.7 en video

30 TEMA 16.7 · SEBORREICA Y DE CONTACTO

FOTO CLÍNICA

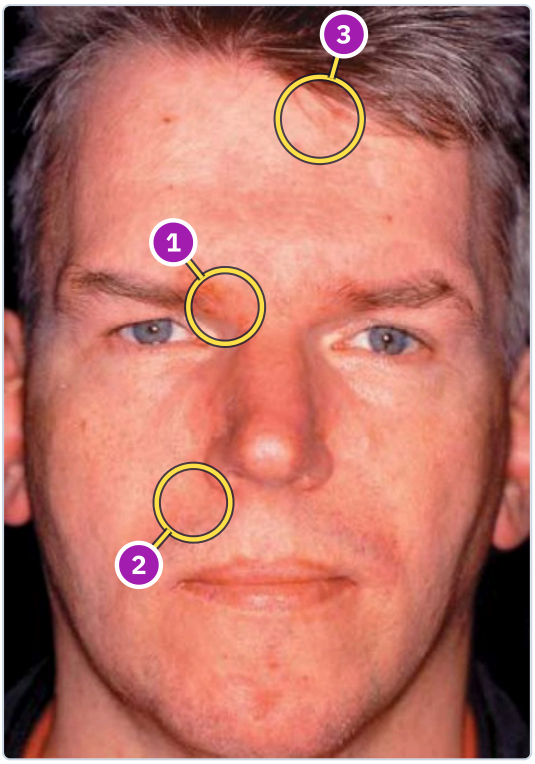


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 260

QUÉ TIENES QUE VER

1. Entrecejo y cejas
2. Surcos nasogenianos
3. Eritema en la frente

DIAGNÓSTICO

Dermatitis seborreica del adulto

Escamas grasosas amarillentas en zonas de alta densidad sebácea (Malassezia).

CONDUCTA INICIAL

Champú de ketoconazol 2% + corticoide de baja potencia en ciclos cortos; si es severa y refractaria, pedir VIH.

6.01.1.006 Dermatitis seborreica infantil y del adulto
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Rosácea: pápulas y pústulas sobre eritema, sin escamas grasosas.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P12** «Un niño de 20 días de edad, presenta lesiones eritematosas, con descamación en la cabeza y la zona interciliar, con descamación amarilla, de…» → **Vaselina topica**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 35** Tema 16.7

Clase 16.7 en video

31 TEMA 16.7 · SEBORREICA Y DE CONTACTO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 869

QUÉ TIENES QUE VER

1. Eritema y edema en las mejillas
2. Frente comprometida
- Respeta zonas sombreadas (párpados superiores, submentoniano)

DIAGNÓSTICO

Fototoxicidad

Reacción no inmune y dosis dependiente: parece una quemadura solar exagerada en zonas expuestas.

CONDUCTA INICIAL

Suspender el fármaco (doxiciclina, amiodarona, tiazidas…), fotoprotección FPS 50+ y corticoide tópico.

6.01.1.011 Fotodermatosis
Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fotoalergia: tipo IV, eccematosa y desborda a zonas cubiertas.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P115** «Un paciente de 25 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades in- feriores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol y que las…» → **Fitodermatitis**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 35** Tema 16.7

Clase 16.7 en video

32 TEMA 16.8 · URTICARIA Y ANGIOEDEMA

FOTO CLÍNICA

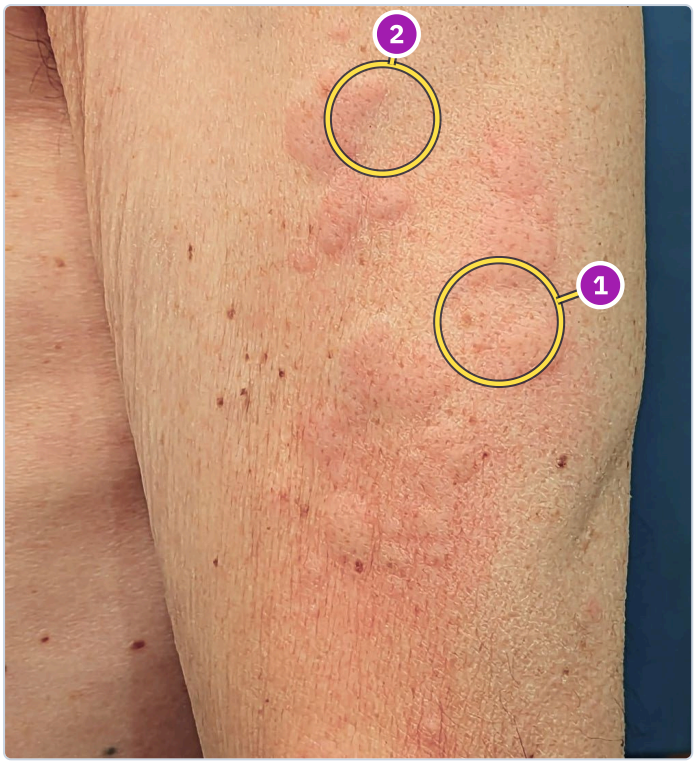


Imagen: Manual AMIR Dermatología

QUÉ TIENES QUE VER

1. Habones sobreelevados, rosados
2. Confluyen en placas de borde geográfico

DIAGNÓSTICO

Urticaria aguda

Habones evanescentes y pruriginosos: cada lesión desaparece en menos de 24 horas sin marca.

CONDUCTA INICIAL

Antihistamínico H1 de 2.ª generación; si no responde en 2–4 semanas, cuadruplicar la dosis.

6.01.1.030	Urticaria aguda — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
6.01.2.016	Urticaria y angioedema — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Vasculitis urticariana: fija más de 24–48 h, arde y deja púrpura (biopsia).

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P20** «Mujer de 28 años con urticaria generalizada de 48h de evolución, prurito intenso. Sin angioedema ni compromiso hemodinámico. ¿Cuál es el…» → **Levocetirizina oral**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 41 Tema 16.8

Clase 16.8 en video

33 TEMA 16.8 · URTICARIA Y ANGIOEDEMA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 50

QUÉ TIENES QUE VER

1. Labio inferior tumefacto, tenso y deformado
- Buscar estridor, disnea o hipotensión: anafilaxia

DIAGNÓSTICO

Angioedema labial

Edema de dermis profunda y submucosa: tumefacción tensa que tarda 48–72 h en reabsorberse.

CONDUCTA INICIAL

Si hay compromiso respiratorio o hemodinámico: adrenalina IM 0,3–0,5 mg en el muslo.

6.01.2.001	Angioedema de Quinque — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.01.2.016	Urticaria y angioedema — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Habón: dermis superficial, pruriginoso, dura menos de 24 h.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P152** «Una niña de 6 años, desde hace dos horas presenta edema de los labios, más aparición de múltiples lesiones habonosas y pseudopapulares…» → **Adrenalina**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 39 Tema 16.8

Clase 16.8 en video

34 TEMA 16.9 · SSJ / NET

FOTO CLÍNICA

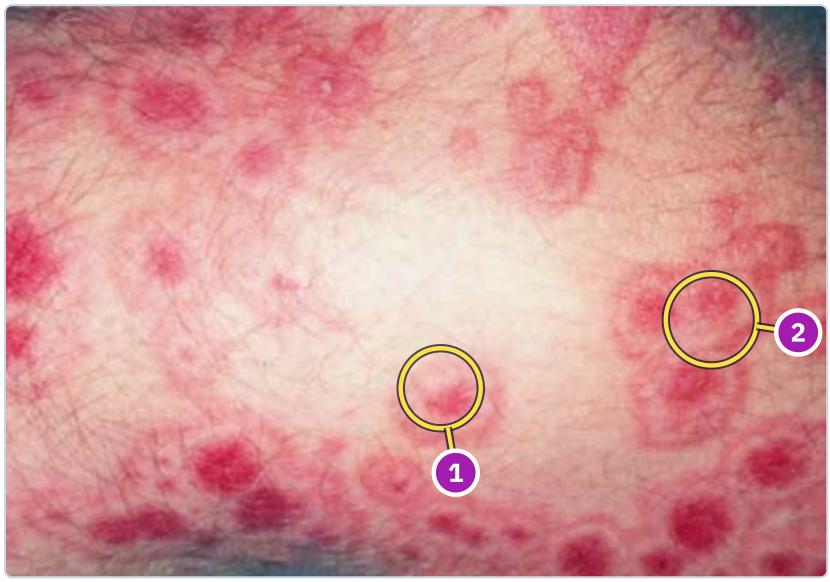


Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., p. 414

QUÉ TIENES QUE VER

1. Diana atípica: centro purpúrico y 2 anillos
2. Máculas que confluyen en el tronco

DIAGNÓSTICO

Stevens-Johnson: dianas atípicas

Dianas de solo 2 anillos con centro purpúrico o ampollar, en el tronco, con dolor desproporcionado.

CONDUCTA INICIAL

Suspender ya el fármaco sospechoso y hospitalizar (UCI o centro de quemados).

6.01.2.015	Síndrome de Stevens-Johnson	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Eritema multiforme: diana típica de 3 anillos, acral, Nikolsky negativo.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P94** «Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los…» → **Síndrome de Stevens-Johnson**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 45 Tema 16.9

Clase 16.9 en video

35 TEMA 16.9 · SSJ / NET

FOTO CLÍNICA

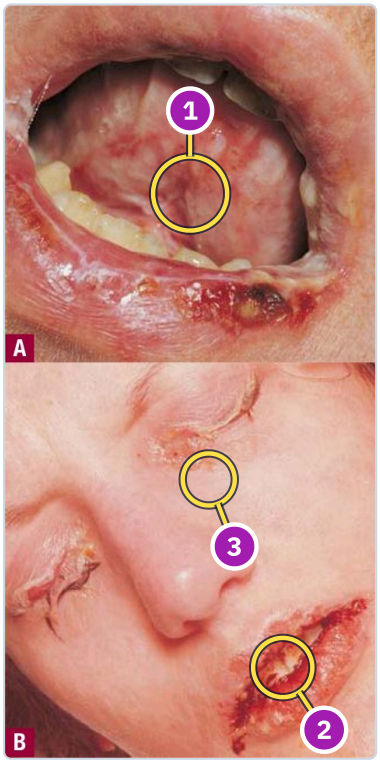


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 390

QUÉ TIENES QUE VER

1. Erosiones de la mucosa oral (A)
2. Costras hemáticas en los labios (B)
3. Compromiso ocular (B)

DIAGNÓSTICO

Necrólisis epidérmica: mucosas

Compromiso de mucosas en más del 90%: oral, ocular y urogenital.

CONDUCTA INICIAL

Interconsulta oftalmológica desde el día 1 (lágrimas artificiales, lisis de sinequias) para evitar simblefaron.

6.01.2.009	Necrolisis tóxica epidérmica	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
6.01.2.015	Síndrome de Stevens-Johnson	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Síndrome de piel escaldada: mucosas respetadas.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P48** «Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta…» → **Necrosis epidermolítica tóxica**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 46 Tema 16.9

Clase 16.9 en video

36 TEMA 16.9 · SSJ / NET

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 105

QUÉ TIENES QUE VER

1. Dermis roja denudada en la espalda
2. Epidermis desprendida en sábanas

DIAGNÓSTICO

Necrólisis epidérmica tóxica

Desprendimiento de más del 30% de la superficie corporal: piel de gran quemado.

CONDUCTA INICIAL

Retiro inmediato del fármaco, centro de quemados a 30–32 °C y nunca desbridar.

6.01.2.009 Necrolisis tóxica epidérmica

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

SSJ: menos del 10% desprendido; superposición entre 10 y 30%.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P80** «Una paciente de 45 años inicia tratamiento antibiótico debido a una infección dental. Al séptimo día de tratamiento presenta erupción…» → **Necrólisis epidérmica tóxica**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 45 Tema 16.9

Clase 16.9 en video

37 TEMA 16.9 · SSJ / NET

FOTO CLÍNICA

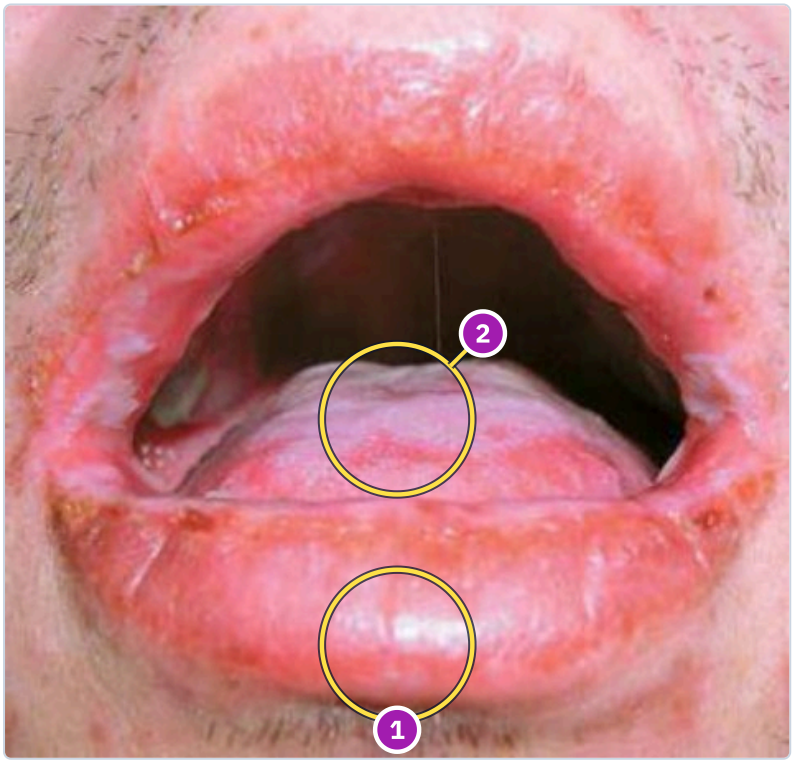


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 685

QUÉ TIENES QUE VER

1. Erosiones y costras en el labio inferior
2. Erosiones de la mucosa oral

DIAGNÓSTICO

Stevens-Johnson: labios

Queilitis costrosa hemorrágica y estomatitis: 2 o más mucosas comprometidas.

CONDUCTA INICIAL

Suspender el fármaco y hospitalizar; SSJ = menos del 10% de piel desprendida.

6.01.2.015 Síndrome de Stevens-Johnson

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Eritema multiforme major: mucosas, pero sin desprendimiento y Nikolsky negativo.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P103** «Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea hace 14 días, presenta ardor ocular, lesiones en la boca, malestar…» → **Síndrome de Stevens-Johnson**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 46 Tema 16.9

Clase 16.9 en video

38 TEMA 16.9 · SSJ / NET

FOTO CLÍNICA

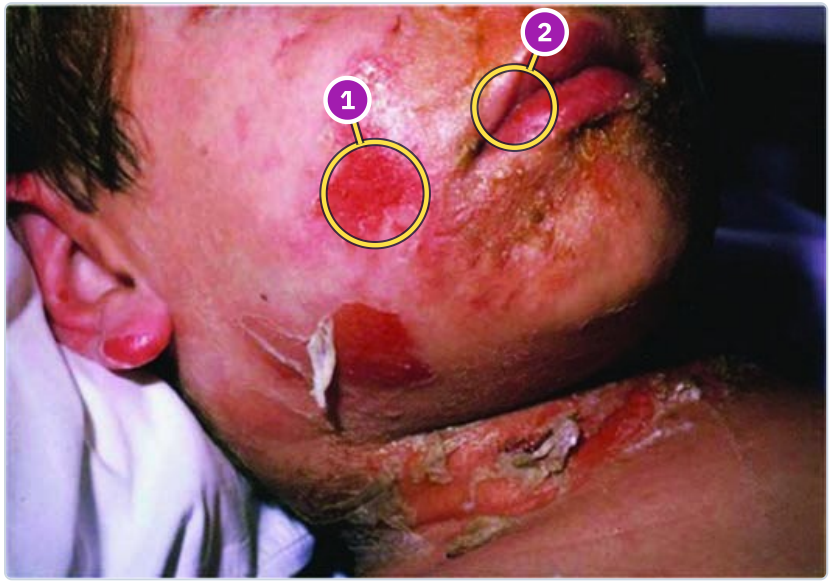


Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., p. 1225

QUÉ TIENES QUE VER

1. Erosiones húmedas «escaldadas»
2. Costras periorificiales

DIAGNÓSTICO

Síndrome de piel escaldada estafilocócica

Toxinas exfoliativas de S. aureus: erosiones «escaldadas», Nikolsky positivo y mucosas respetadas.

CONDUCTA INICIAL

Hospitalizar: cloxacilina EV (vancomicina si se sospecha SARM); sin corticoides.

6.01.2.014 **Síndrome de piel escaldada por estafilococos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

SSJ/NET: dianas atípicas y mucosas comprometidas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 47** Tema 16.9

Clase 16.9 en video

39 TEMA 16.10 · DRESS Y TOXIDERMIAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 9

QUÉ TIENES QUE VER

1. Máculas y pápulas eritematosas confluentes
2. Distribución extensa y simétrica

DIAGNÓSTICO

Exantema morbiliforme (maculopapular)

La reacción medicamentosa más frecuente: máculas y pápulas simétricas a los 4–14 días.

CONDUCTA INICIAL

Suspender el fármaco, antihistamínico, corticoide tópico y control en 48–72 h.

6.01.1.025 **Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija)**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

DRESS o SSJ si hay fiebre alta, edema facial, ampollas, mucosas o eosinofilia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 52** Tema 16.10

Clase 16.10 en video

40 TEMA 16.10 · DRESS Y TOXIDERMIAS

FOTO CLÍNICA

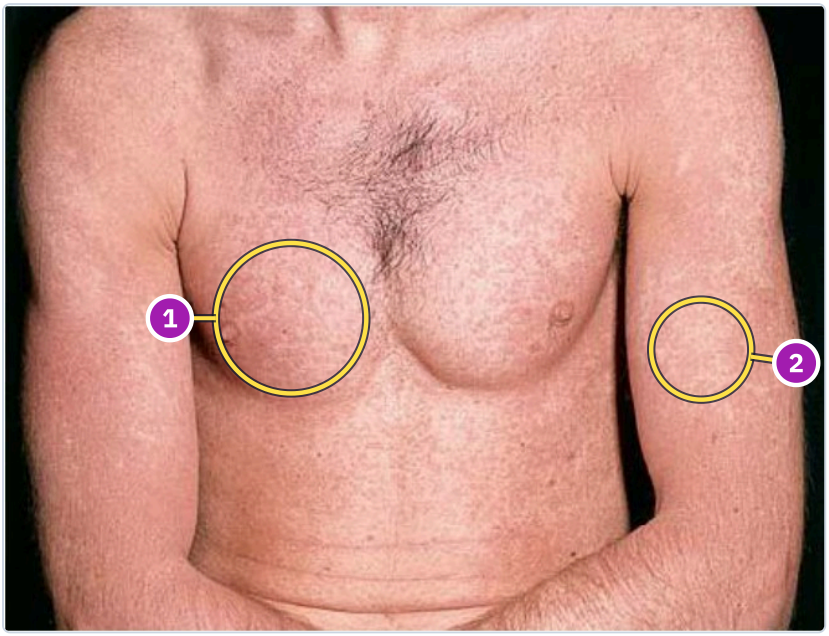


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 40-2

QUÉ TIENES QUE VER

1. Exantema confluente en el tronco
2. Se extiende a las extremidades

DIAGNÓSTICO

DRESS: exantema del tronco

Exantema morbiliforme confluente con fiebre, 2–8 semanas después del fármaco.

CONDUCTA INICIAL

Retirar el fármaco y pedir hemograma (eosinofilia) y perfil hepático.

6.01.2.013 Síndrome de hipersensibilidad a drogas

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Exantema simple: 4–14 días, sin fiebre alta ni edema facial.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA p. 50 Tema 16.10

Clase 16.10 en video

41 TEMA 16.10 · DRESS Y TOXIDERMIAS

FOTO CLÍNICA

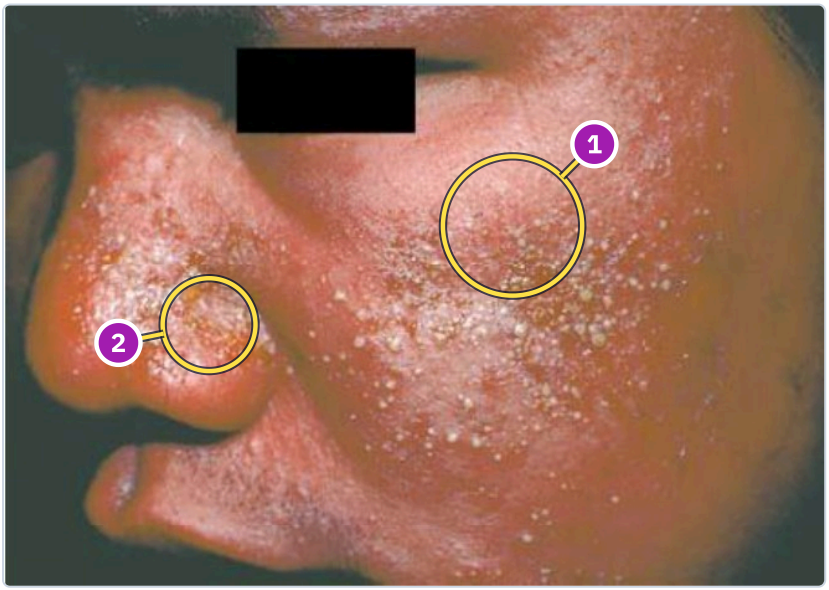


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 40-3

QUÉ TIENES QUE VER

1. Edema malar prominente con lesiones
2. Compromiso de nariz y labio

DIAGNÓSTICO

DRESS: edema facial

El edema periorbitario y malar es el hallazgo que más orienta; Nikolsky negativo.

CONDUCTA INICIAL

Prednisona 0,5–1 mg/kg/día con descenso muy lento, en 2–3 meses.

6.01.2.013 Síndrome de hipersensibilidad a drogas

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Stevens-Johnson/NET: dianas atípicas, ampollas, Nikolsky positivo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA p. 49 Tema 16.10

Clase 16.10 en video

42 TEMA 16.10 · DRESS Y TOXIDERMIAS

FOTO CLÍNICA

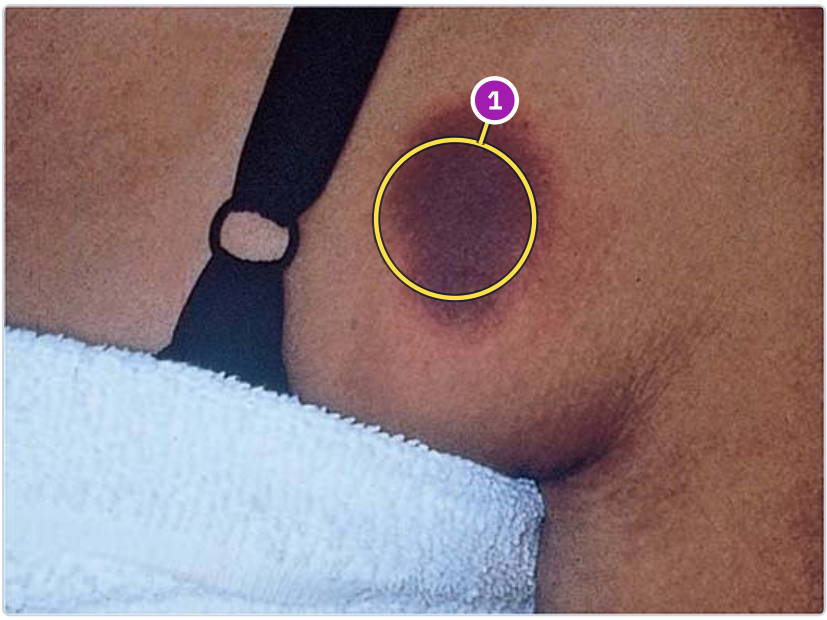


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 392

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa violácea redonda, bien delimitada
2. Deja mancha parda residual

DIAGNÓSTICO

Toxidermia fija

Placa violácea redonda que reaparece siempre en el mismo sitio con el mismo fármaco.

CONDUCTA INICIAL

Suspender el fármaco (AINE, cotrimoxazol, tetraciclinas), corticoide tópico potente y registrar el agente.

6.01.1.025	Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija)	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Exantema morbiliforme: máculas y pápulas difusas, no una placa única.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 52** Tema 16.10

Clase 16.10 en video

43 TEMA 16.11 · PÉNFIGO Y PENFIGOIDE

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

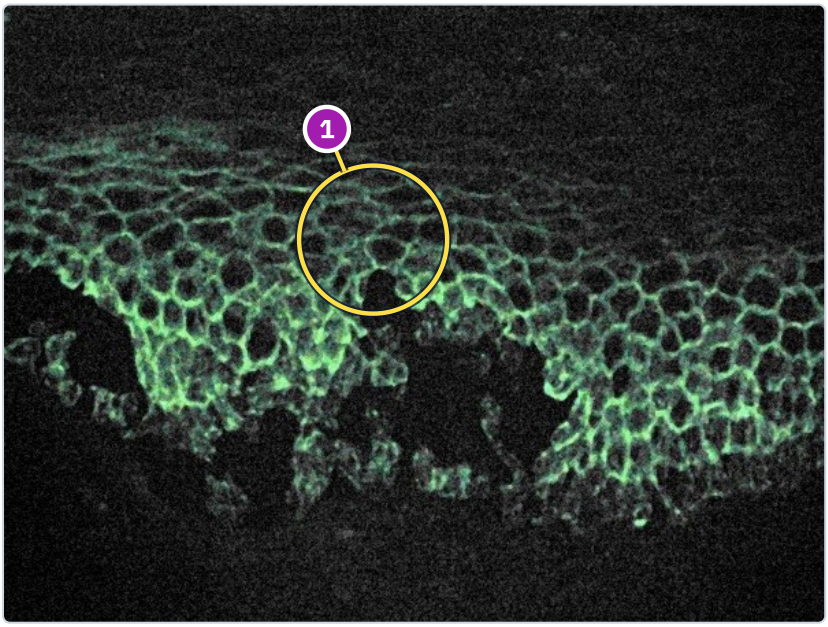


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Patrón en red de pescar (panal de abejas)
2. La piel sana perilesional va en medio de Michel, no en formalina

DIAGNÓSTICO

IFD de pénfigo vulgar

Depósito intercelular de IgG y C3 «en red de pescar» entre los queratinocitos.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia: borde de ampolla reciente en formalina + piel sana a 1 cm en medio de Michel.

6.01.5.001	Biopsia de piel	examen/procedimiento
6.01.1.020	Pénfigo	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Penfigoide: depósito lineal continuo en la membrana basal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 54** Tema 16.11

Clase 16.11 en video

44 TEMA 16.11 · PÉNFIGO Y PENFIGOIDE

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 49

QUÉ TIENES QUE VER

1. Erosiones costrosas: ampollas flácidas rotas
2. Lesiones sobre piel aparentemente sana

DIAGNÓSTICO

Péngigo vulgar

Ampollas flácidas que se rompen y dejan erosiones dolorosas; Nikolsky positivo.

CONDUCTA INICIAL

Prednisona oral 1–1,5 mg/kg/día + rituximab; biopsia con IFD.

6.01.1.020 Pénfigo — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

6.01.2.010 Pénfigo y penfigoide — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Penfigoide ampollar: ampolla tensa, Nikolsky negativo, ancianos con prurito.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 54** Tema 16.11

Clase 16.11 en video

46 TEMA 16.11 · PÉNFIGO Y PENFIGOIDE

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Erosión en la mucosa yugal
2. Paladar comprometido

DIAGNÓSTICO

Péngigo vulgar oral

La boca avisa antes que la piel (70–90%): erosiones dolorosas, rara vez ampollas intactas.

CONDUCTA INICIAL

Derivar para biopsia con IFD; prednisona oral en dosis altas.

6.01.1.020 Pénfigo — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Penfigoide ampollar: casi siempre respeta la boca.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 55** Tema 16.11

Clase 16.11 en video

45 TEMA 16.11 · PÉNFIGO Y PENFIGOIDE

FOTO CLÍNICA

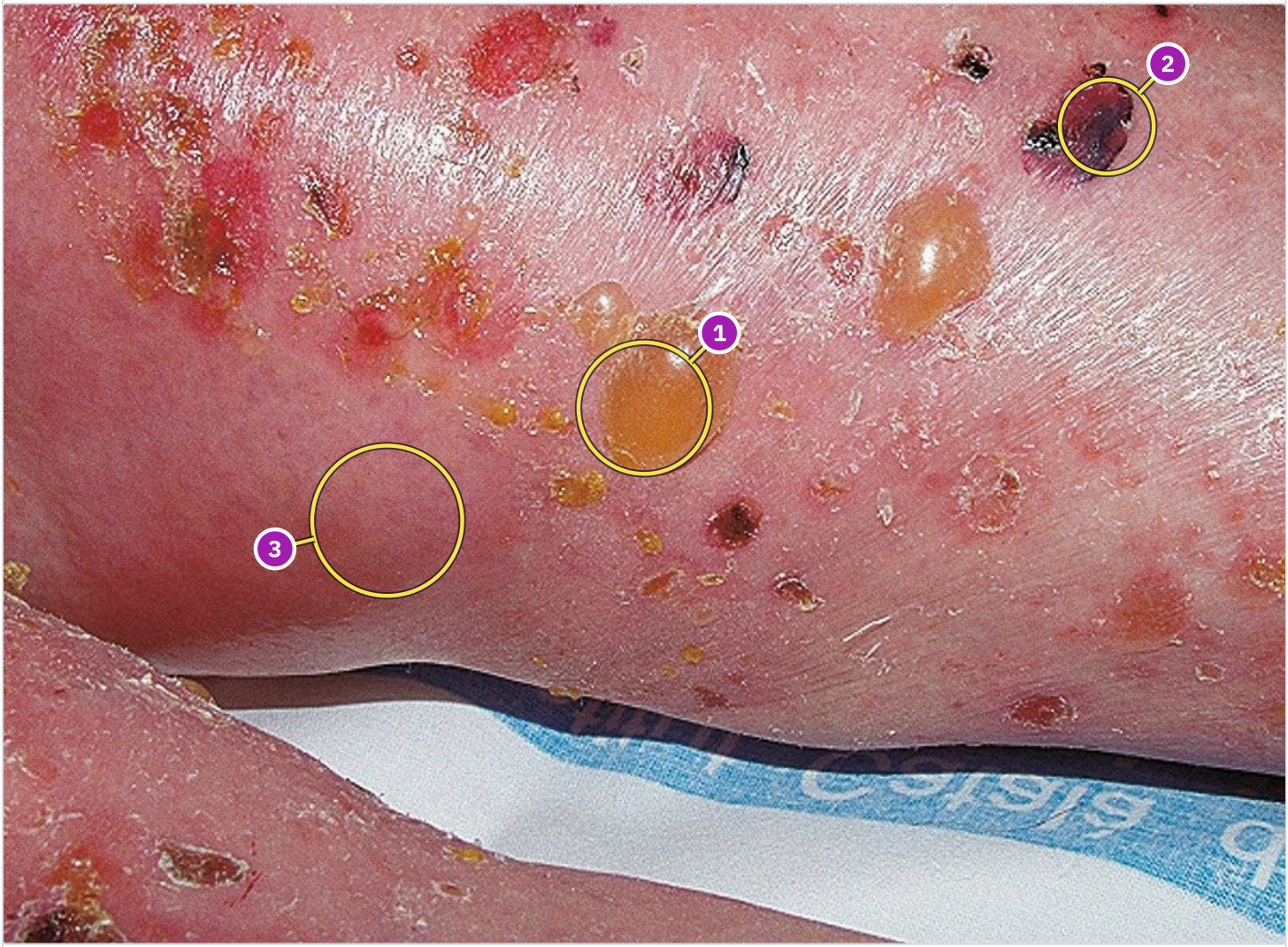


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 49

QUÉ TIENES QUE VER

1. Ampolla tensa de contenido seroso
2. Ampolla de contenido hemorrágico
3. Base eritematosa y edematosa

CONDUCTA INICIAL

Clobetasol tópico en todo el cuerpo; prednisona 0,5 mg/kg/día si es extenso.

6.01.2.010 **Péndigo y penfigoide**

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

DIAGNÓSTICO

Penfigoide ampollar

Ampollas tensas subepidérmicas, Nikolsky negativo, en ancianos con prurito intenso.

SE CONFUNDE CON…

Pénfigo vulgar: ampolla flácida, Nikolsky positivo, boca comprometida.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA p. 54 Tema 16.11

Clase 16.11 en video

47 TEMA 16.12 · ERITEMA MULTIFORME Y VIRUS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 106

QUÉ TIENES QUE VER

1. Diana: centro oscuro, anillo pálido, halo rojo
2. Distribución acral (pie)

DIAGNÓSTICO

Eritema multiforme

Dianas típicas de 3 anillos, acrales y simétricas, tras un herpes simple.

CONDUCTA INICIAL

Sintomático (antihistamínico, corticoide tópico); aciclovir si hay herpes activo o recurrencias.

6.01.1.010 Eritema polimorfo menor

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Stevens-Johnson: diana atípica de 2 anillos, tronco, Nikolsky positivo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 61** Tema 16.12

Clase 16.12 en video

48 TEMA 16.12 · ERITEMA MULTIFORME Y VIRUS

FOTO CLÍNICA

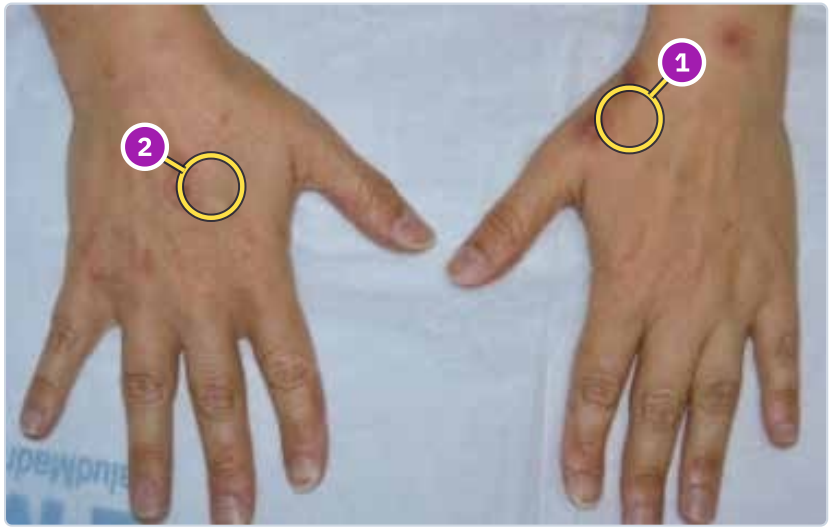


Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 15

QUÉ TIENES QUE VER

1. Dianas en el dorso de la mano
2. También en la otra mano

DIAGNÓSTICO

Eritema multiforme: dianas en las manos

El dorso de las manos es la localización típica: bilateral y simétrica.

CONDUCTA INICIAL

Autolimitado en 2–4 semanas; aciclovir profiláctico 6 meses si hay 3–5 brotes al año.

6.01.1.010 Eritema polimorfo menor

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Stevens-Johnson: centrípeto, con desprendimiento epidérmico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 61** Tema 16.12

Clase 16.12 en video

49 TEMA 16.12 · ERITEMA MULTIFORME Y VIRUS

FOTO CLÍNICA

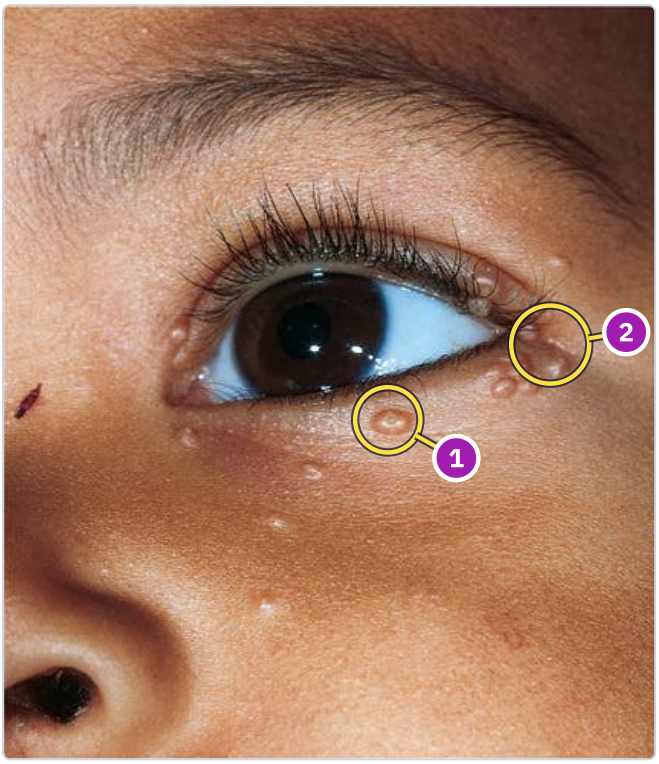


Imagen: Kumar & Clark, Clinical Medicine, Fig. 45.28

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pápula perlada umbilicada
2. Varias lesiones periorbitarias

DIAGNÓSTICO

Molusco contagioso

Poxvirus: pápulas perladas umbilicadas de 2 a 5 mm, típicas en niños.

CONDUCTA INICIAL

Autolimitado; curetaje o crioterapia; evitar el rascado y compartir toallas.

6.01.1.031 **Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Verruga vulgar: pápula hiperqueratósica rugosa, sin umbilicación.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 60** Tema 16.12

Clase 16.12 en video

50 TEMA 16.12 · ERITEMA MULTIFORME Y VIRUS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

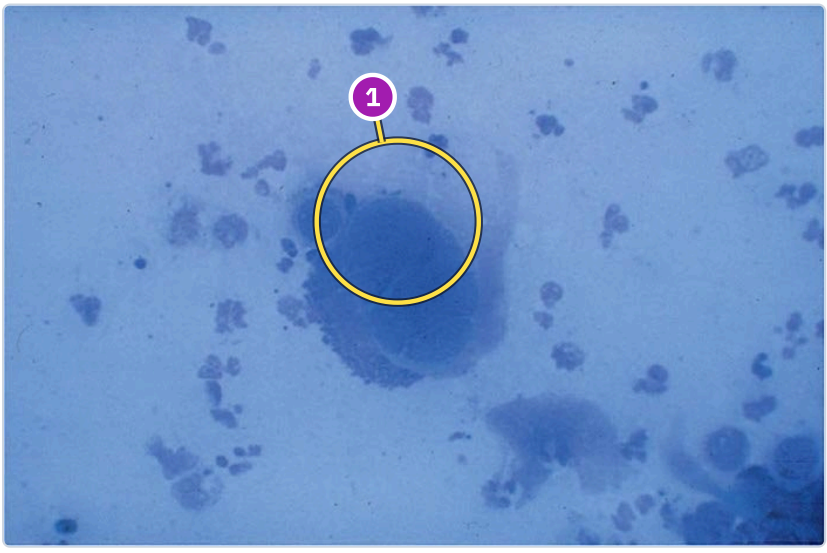


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 947

QUÉ TIENES QUE VER

1. Célula gigante multinucleada
- Sensibilidad 60–70%: un negativo no descarta herpes

DIAGNÓSTICO

Test de Tzanck: célula gigante multinucleada

Células gigantes multinucleadas: herpes simple o varicela-zóster (no los distingue).

CONDUCTA INICIAL

Destechar una vesícula reciente, raspar el piso y teñir con Giemsa; si es negativo, PCR.

6.01.4.006 **Test TZANCK**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Pénfigo: queratinocitos acantolíticos aislados, sin multinucleación.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 60** Tema 16.12

Clase 16.12 en video

51 TEMA 16.12 · ERITEMA MULTIFORME Y VIRUS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 1929

QUÉ TIENES QUE VER

1. Costra hemorrágica
2. Lesiones en otras etapas

DIAGNÓSTICO

Herpes zóster diseminado

Lesiones en distintas etapas (vesículas, pústulas, costras) en inmunosuprimidos.

CONDUCTA INICIAL

Antiviral dentro de las 72 h: aciclovir, valaciclovir o famciclovir por 7 días.

`6.01.1.031` **Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`6.01.2.007` **Herpes zoster**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Varicela: vesículas en distintos estadios con fiebre y lesiones en mucosas.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P158 «Una paciente de 76 años, diabética, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, asociada a…» → **Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 7 días**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 60** Tema 16.12

Clase 16.12 en video

52 TEMA 16.12 · ERITEMA MULTIFORME Y VIRUS

FOTO CLÍNICA

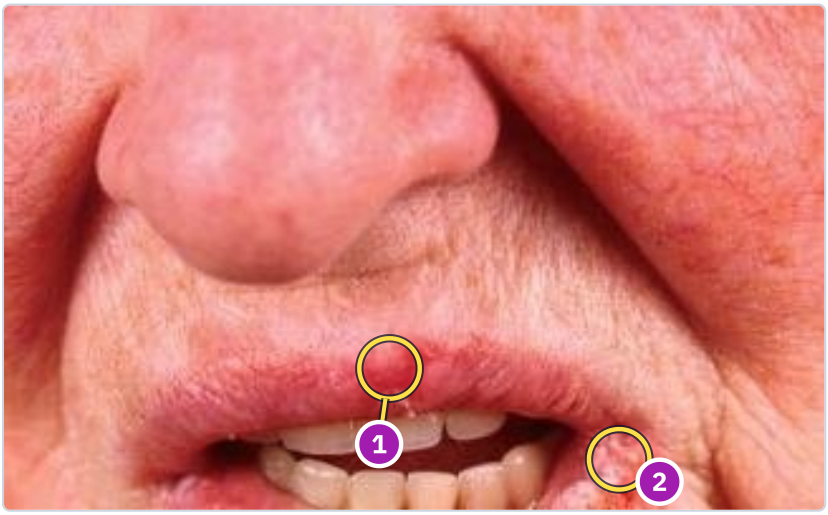


Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 1955

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lesión hiperqueratósica en el labio
2. Otra lesión en la comisura

DIAGNÓSTICO

Verruga vulgar

VPH 1, 2 y 4: pápula o nódulo hiperqueratósico rugoso.

CONDUCTA INICIAL

Ácido salicílico 15–40% + crioterapia cada 2–3 semanas; derivar si no responde en 3 meses.

`6.01.1.031` **Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Molusco contagioso: pápula perlada umbilicada.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P86 «Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primero ortejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada,…» → **Verruga vulgar**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 61** Tema 16.12

Clase 16.12 en video

53 TEMA 16.13 · MELANOMA

FOTO CLÍNICA

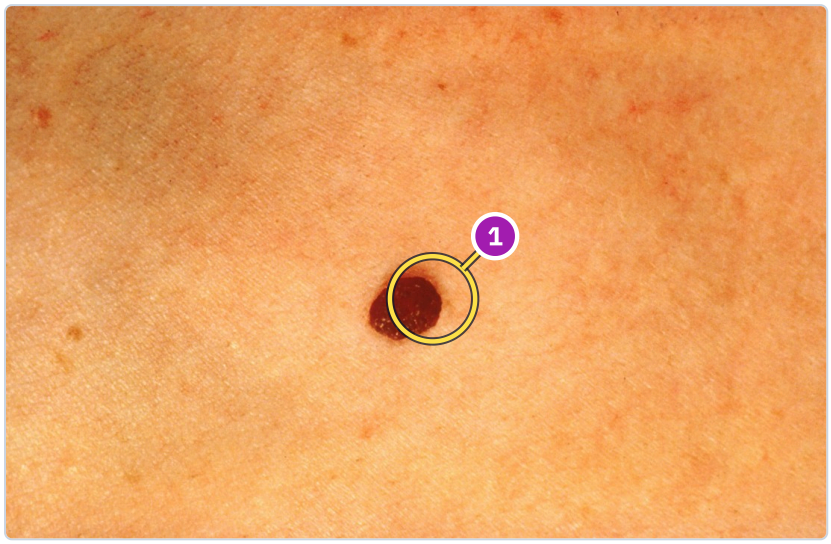


Imagen: Wikimedia Commons, Public domain

QUÉ TIENES QUE VER

1. Simétrico, borde regular, color homogéneo
- Estable en el tiempo: la E (evolución) es el criterio más sensible

DIAGNÓSTICO

Nevo melanocítico común

Simétrico, borde regular, color homogéneo y menor de 6 mm: ABCDE negativo.

CONDUCTA INICIAL

Benigno: fotografía y control; mapeo si tiene más de 50 nevos o antecedente de melanoma.

6.01.1.017	Melanoma maligno	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.01.4.002	Dermatoscopía	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Melanoma: asimetría, bordes irregulares, varios colores, más de 6 mm o evolución.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P178** «Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al...» → **Melanoma**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 69** Tema 16.13

Clase 16.13 en video

54 TEMA 16.13 · MELANOMA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulo negro-azulado en la mejilla
- A la derecha, la misma zona un año después: E de evolución

DIAGNÓSTICO

Melanoma nodular

El subtipo más agresivo: crecimiento vertical desde el inicio, nódulo azul-negro.

CONDUCTA INICIAL

Derivar de inmediato y biopsia excisional completa (margen 1–2 mm con hipodermis).

6.01.1.017	Melanoma maligno	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nevo común: estable, simétrico y homogéneo.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P115** «Paciente de 90 años con 3 lesiones pigmentadas de crecimiento progresivo en la pierna. La mayor se muestra en imagen. ¿Diagnóstico más probable?» → **Melanoma con satelitosis**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 68** Tema 16.13

Clase 16.13 en video

55 TEMA 16.13 · MELANOMA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 78

QUÉ TIENES QUE VER

1. Asimetría y bordes irregulares
2. Color heterogéneo: negro, azulado, blanco y rojo

DIAGNÓSTICO

Melanoma: regla ABCDE

Asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro mayor de 6 mm y evolución.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia excisional completa: nunca shave ni punch (amputan el Breslow).

`6.01.1.017` Melanoma maligno — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

`6.01.5.001` Biopsia de piel — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Nevo común: simétrico, borde regular, un solo color.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P178 «Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al…» → **Melanoma**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 68** Tema 16.13

Clase 16.13 en video

56 TEMA 16.13 · MELANOMA

FOTO CLÍNICA

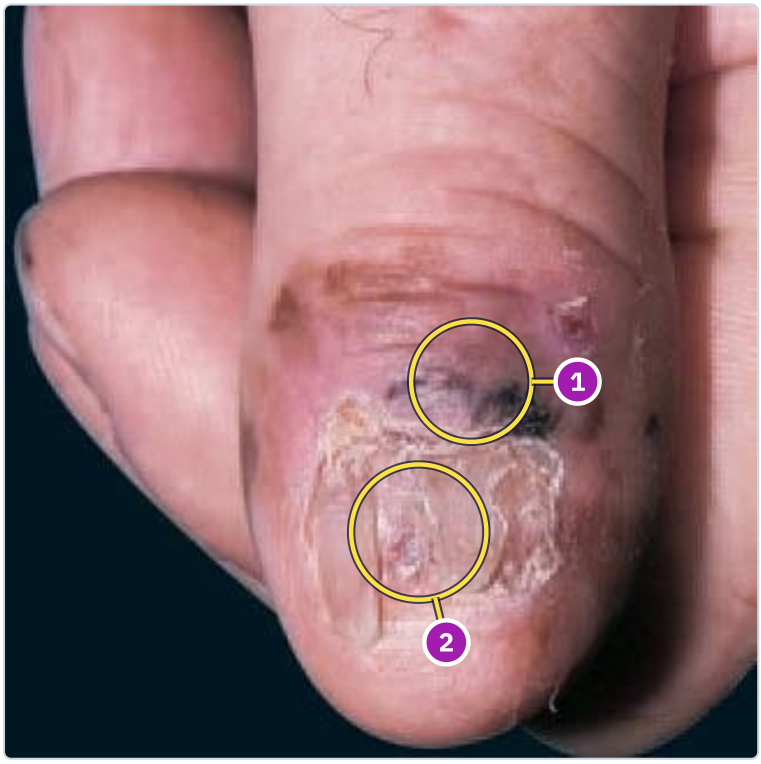


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pigmento que invade el pliegue ungueal (signo de Hutchinson)
2. Lámina ungueal distrófica

DIAGNÓSTICO

Melanoma lentiginoso acral subungueal

Más de la mitad de los melanomas en Chile; no depende del sol.

CONDUCTA INICIAL

Sospecharlo aunque no tome sol: biopsia excisional y derivar.

`6.01.1.017` Melanoma maligno — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Melanoniquia sin invasión del pliegue (sin signo de Hutchinson).

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 68** Tema 16.13

Clase 16.13 en video

57 TEMA 16.14 · CBC Y CEC

FOTO CLÍNICA

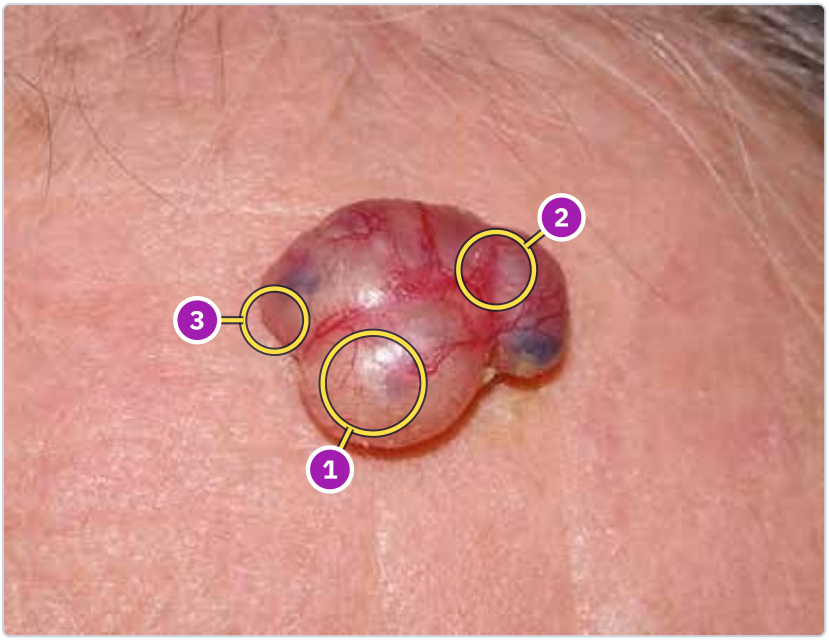


Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 99

QUÉ TIENES QUE VER

1. Aspecto perlado, translúcido y brillante
2. Telangiectasias superficiales ramificadas
3. Borde arrollado

DIAGNÓSTICO

Carcinoma basocelular nodular

Pápula perlada translúcida con telangiectasias y borde arrollado: el cáncer de piel más frecuente.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia si hay duda y derivar; escisión con margen cercano a 4 mm o Mohs en la zona H.

6.01.1.003 **Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Carcinoma espinocelular: placa queratósica costrosa indurada, que sí metastiza.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P63** «Una paciente de 58 consulta por aparición de una lesión pruriginosa, de 3 meses de evolución en el párpado inferior derecho, que ha aumentado de…» → **Carcinoma basocelular**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 74** Tema 16.14

Clase 16.14 en video

58 TEMA 16.14 · CBC Y CEC

FOTO CLÍNICA

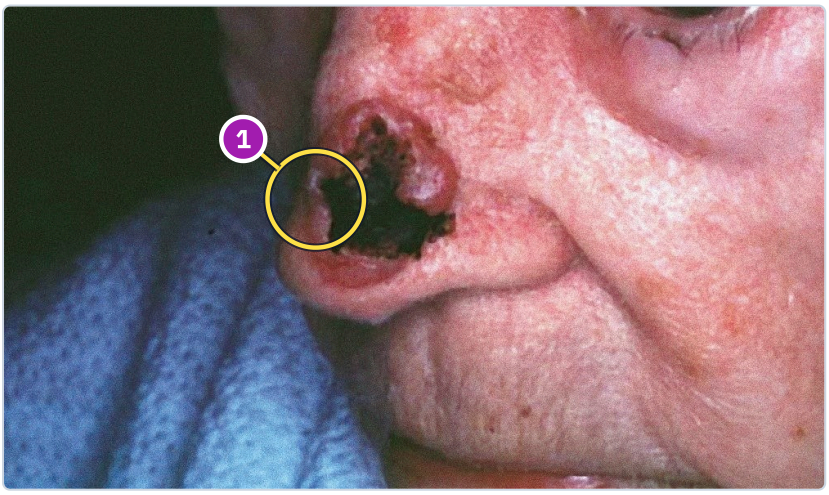


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 76

QUÉ TIENES QUE VER

1. Úlcera central que destruye el ala nasal
- Nariz = zona H de la cara: cirugía de Mohs

DIAGNÓSTICO

Úlcera de Rodent (CBC ulcerado)

El CBC casi no metastiza (< 0,01%), pero destruye cartílago, hueso u órbita.

CONDUCTA INICIAL

Derivar: cirugía micrográfica de Mohs (zona H, recurrente o mayor de 2 cm).

6.01.1.003 **Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Carcinoma espinocelular ulcerado (indurado, con riesgo de metástasis).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 74** Tema 16.14

Clase 16.14 en video

59 TEMA 16.14 · CBC Y CEC

FOTO CLÍNICA

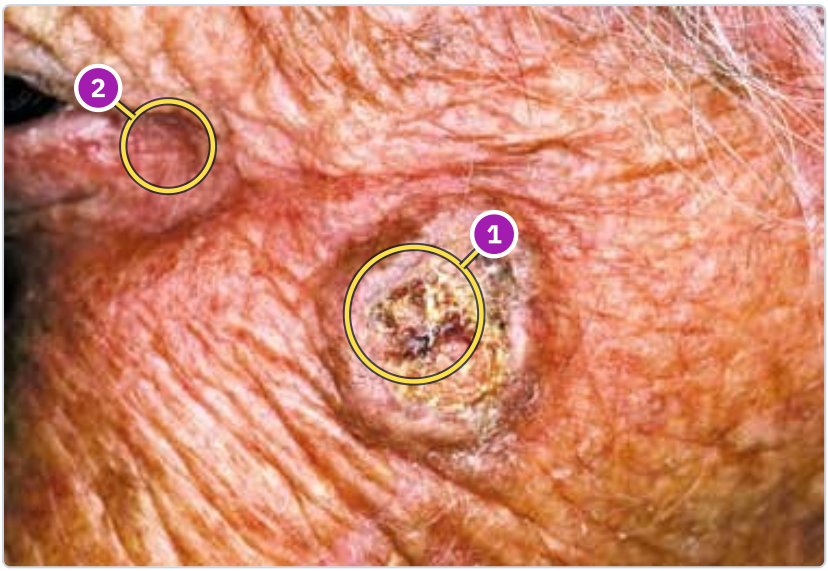


Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 100

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulo con costra hiperqueratósica central
2. Piel con daño solar crónico alrededor

DIAGNÓSTICO

Carcinoma espinocelular

Placa o nódulo queratósico indurado que sangra o se ulcera, sobre piel con daño solar.

CONDUCTA INICIAL

Derivar con prioridad: escisión con margen de 4–6 mm (6–10 mm si es de alto riesgo).

6.01.1.003 **Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Queratosis actínica: mácula áspera sin induración.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 74** Tema 16.14

Clase 16.14 en video

60 TEMA 16.14 · CBC Y CEC

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 77

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lesión ulcerada del labio inferior
- Precursor: queilitis actínica

DIAGNÓSTICO

Carcinoma espinocelular del labio

El labio inferior es de alto riesgo: hasta 15–20% de metástasis.

CONDUCTA INICIAL

Derivar con prioridad y evaluar los ganglios regionales.

6.01.1.003 **Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Carcinoma basocelular: excepcional en mucosas.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P80** «Un hombre de 70 años, consulta por una lesión en la mano derecha, que apareció hace 6 meses y que ha crecido progresivamente. Es dolorosa y se…» → **Carcinoma espinocelular**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 74** Tema 16.14

Clase 16.14 en video

61 TEMA 16.15 · LESIONES PREMALIGNAS

FOTO CLÍNICA

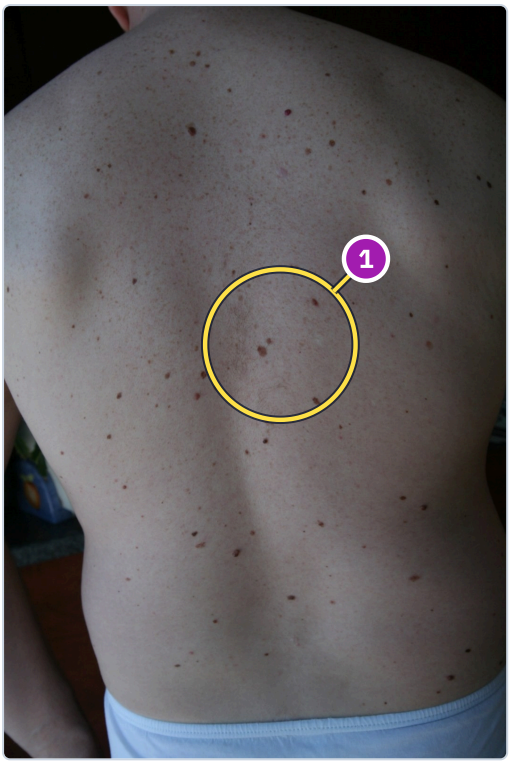


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Numerosos nevos en el tronco
- Buscar el «patito feo»: la lesión distinta de las demás

DIAGNÓSTICO

Nevos displásicos (atípicos)

Marcador de riesgo de melanoma, no lesión maligna; el riesgo sube con más de 50–100 nevos.

CONDUCTA INICIAL

Atipia leve y estable: fotografía seriada; atipia marcada o cambios: biopsia excisional.

6.01.1.029 **Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Melanoma de extensión superficial: ABCDE positivo y evolución.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 78** Tema 16.15

Clase 16.15 en video

62 TEMA 16.15 · LESIONES PREMALIGNAS

FOTO CLÍNICA

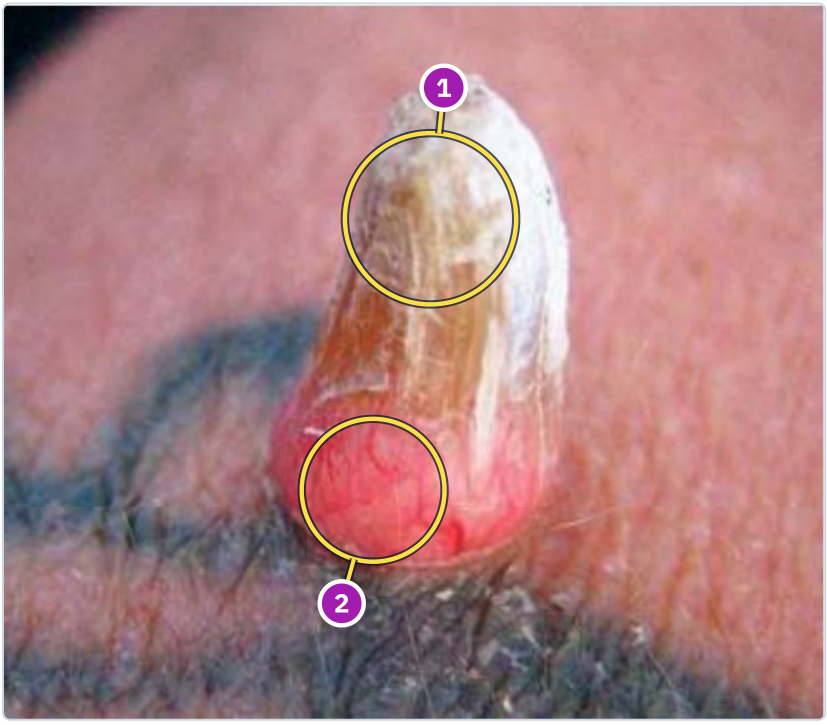


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 66

QUÉ TIENES QUE VER

1. Protrusión cónica hiperqueratósica compacta
2. Base eritematosa: lo que se biopsia

DIAGNÓSTICO

Cuerno cutáneo

Protrusión cónica hiperqueratósica: en su base suele haber una queratosis actínica (60%) o un CEC (20%).

CONDUCTA INICIAL

Biopsiar siempre la base.

6.01.1.029 **Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Verruga viral (también puede estar en la base).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 78** Tema 16.15

Clase 16.15 en video

63 TEMA 16.15 · LESIONES PREMALIGNAS

FOTO CLÍNICA

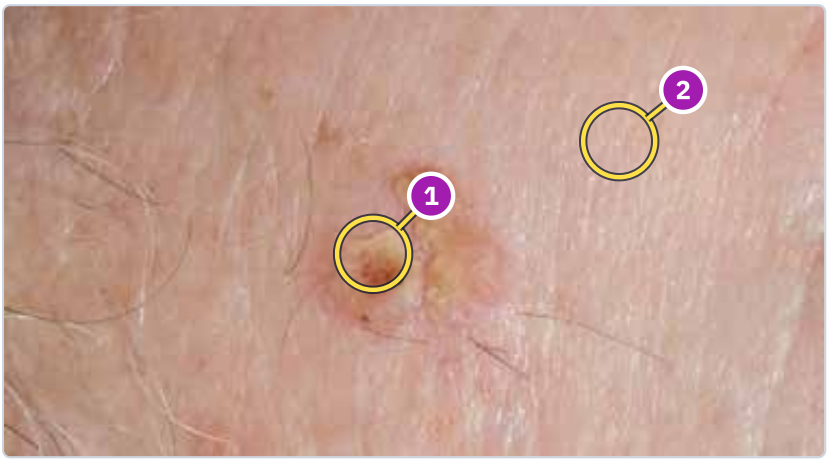


Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 96

QUÉ TIENES QUE VER

1. Mácula eritematosa con escama adherente
2. Piel fotoexpuesta con daño solar

DIAGNÓSTICO

Queratosis actínica

«Se palpa antes de verse»: mácula eritematosa con escama seca, áspera como papel de lija.

CONDUCTA INICIAL

Aislada: crioterapia; múltiples: tratamiento de campo con imiquimod o 5-fluorouracilo.

6.01.1.029 **Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

CEC invasor: base indurada o dolor obligan a biopsiar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 78** Tema 16.15

Clase 16.15 en video

64 TEMA 16.15 · LESIONES PREMALIGNAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 2300

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa eritematosa, escamosa, bien delimitada
- No cede con corticoides ni antifúngicos: biopsia

DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Bowen

Carcinoma espinocelular in situ: placa eritematosa escamosa, solitaria y de crecimiento lento.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia; escisión, curetaje, crioterapia, 5-fluorouracilo o imiquimod.

6.01.1.029 **Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Eccema numular, psoriasis o tiña: el error clásico.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P81** «Un paciente de 72 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en hemodiálisis, presenta aparición de una…» → **Enfermedad de Bowen**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 78** Tema 16.15

Clase 16.15 en video

65 TEMA 16.16 · MICOSIS Y ECTOPARÁSITOS

FOTO CLÍNICA

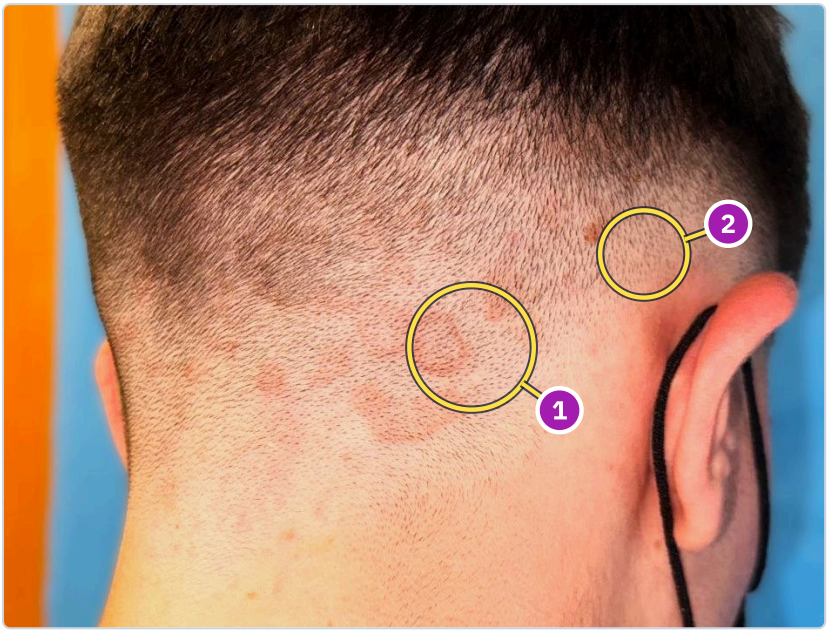


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 63

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa alopécica descamativa en la nuca
2. Otra placa vecina

DIAGNÓSTICO

Tiña capitis

Exclusiva de niños: placas alopécicas con pelos rotos «en sacapuntas» y escamas.

CONDUCTA INICIAL

SIEMPRE oral: griseofulvina 20–25 mg/kg/día por 6–8 semanas (o terbinafina).

`6.01.1.018` Micosis superficiales — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`2.01.1.110` Infecciones micóticas de piel y fanéreos — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Alopecia areata: piel lisa sin escama, pelos en signo de exclamación.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P20** «Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa…» → **Tiña capitis**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 84** Tema 16.16

Clase 16.16 en video

66 TEMA 16.16 · MICOSIS Y ECTOPARÁSITOS

FOTO CLÍNICA

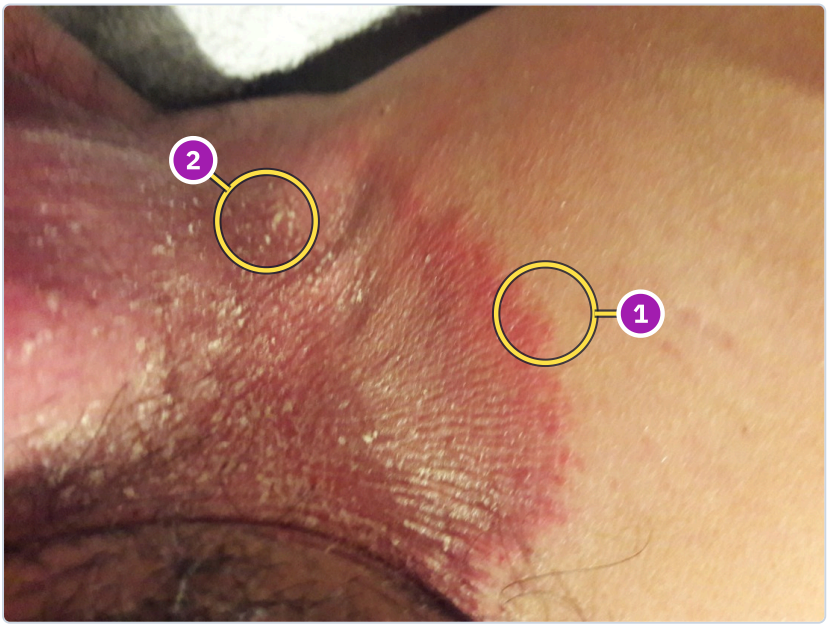


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Borde activo eritematoso y bien definido
2. Descamación sobre la placa

DIAGNÓSTICO

Tiña inguinal (cruris)

Placa eritematosa en el pliegue inguinal con borde activo; respeta el escroto.

CONDUCTA INICIAL

Antifúngico tópico (terbinafina 1%) 2–3 semanas; KOH del borde activo si hay duda.

`6.01.1.018` Micosis superficiales — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Intértrigo candidiásico: compromete el escroto, con lesiones satélites.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P176** «Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen…» → **Intértrigo candidiásico**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 82** Tema 16.16

Clase 16.16 en video

67 TEMA 16.16 · MICOSIS Y ECTOPARÁSITOS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 62

QUÉ TIENES QUE VER

1. Borde activo solevantado y descamativo
2. Centro que aclara

DIAGNÓSTICO

Tiña corporis

Placa anular con borde activo solevantado y descamativo, y centro que aclara.

CONDUCTA INICIAL

Terbinafina tópica 1% cada 12 h por 2–3 semanas; KOH raspando el borde.

6.01.1.018 Micosis superficiales — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

6.01.4.004 Micológico directo de piel, pelos y uñas — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Eccema (no dar corticoide a ciegas), pitiriasis rosada y enfermedad de Bowen.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 82** Tema 16.16

Clase 16.16 en video

68 TEMA 16.16 · MICOSIS Y ECTOPARÁSITOS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 21

QUÉ TIENES QUE VER

1. Máculas hipopigmentadas confluentes
2. Tronco superior y hombro

DIAGNÓSTICO

Pitiriasis versicolor

Máculas hipo o hiperpigmentadas con descamación fina al raspar (signo de la uñada).

CONDUCTA INICIAL

Ketoconazol champú 2% por 2 semanas; KOH: «espaguetis con albóndigas».

6.01.1.018 Micosis superficiales — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

6.01.4.004 Micológico directo de piel, pelos y uñas — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Vitíligo (acrómico, sin escama) y pitiriasis alba.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 84** Tema 16.16

Clase 16.16 en video

69 TEMA 16.16 · MICOSIS Y ECTOPARÁSITOS

FOTO CLÍNICA

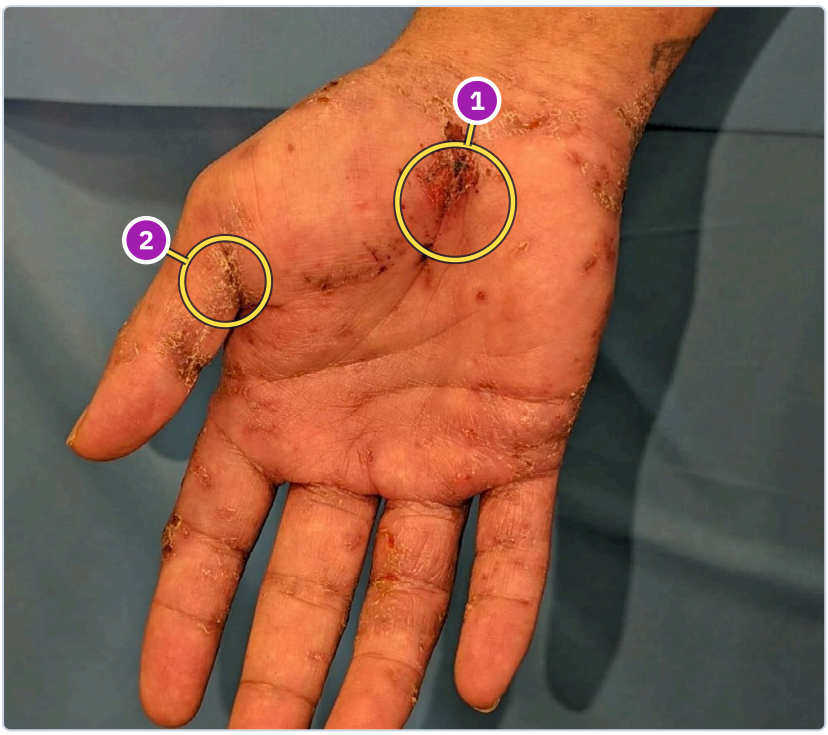


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 69

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lesiones excoriadas en la palma
2. Espacio interdigital: buscar el surco acariano

DIAGNÓSTICO

Escabiosis

Prurito nocturno intenso que afecta a varios en la casa; surcos y vesícula perlada.

CONDUCTA INICIAL

Permetrina 5% del cuello a los pies, repetir a los 7 días y tratar a TODOS los convivientes.

6.01.1.027 **Sarna**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

2.01.1.109 **Ectoparasitosis**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Prúrigo infantil: pápulas con punto central, sin surcos ni contactos.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P144 «Niño de 8 años con lesiones eritematosas papulosas en manos, pies, axilas y zona interdigital, muy pruriginosas, que empeoran de noche. También…» →
Escabiosis: permetrina 5% tópica + tratar a todos los contactos

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 82** Tema 16.16

Clase 16.16 en video

70 TEMA 16.16 · MICOSIS Y ECTOPARÁSITOS

FOTO CLÍNICA

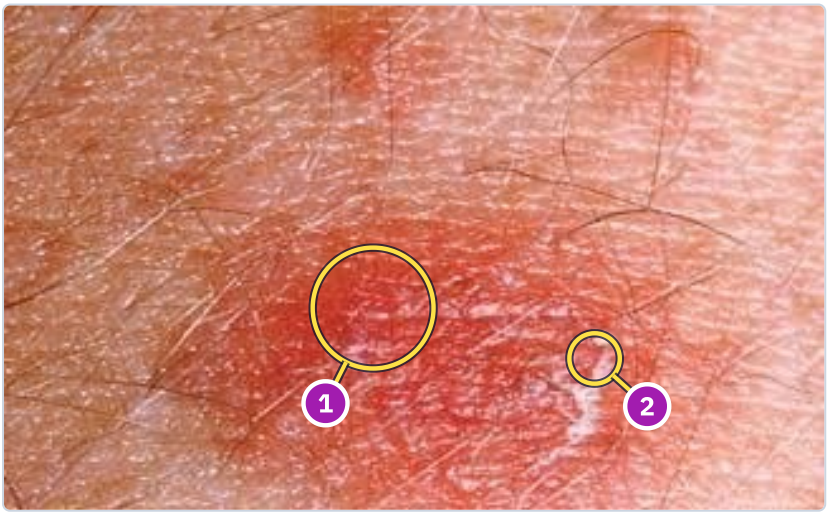


Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 401

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa oval rosada (medallón)
2. Collarete de descamación fina

DIAGNÓSTICO

Pitiriasis rosada: placa heráldica

Placa oval de 2–5 cm con collarete descamativo; luego el «árbol de Navidad».

CONDUCTA INICIAL

Explicar la evolución benigna (6–8 semanas), emolientes y antihistamínico; VDRL si hay riesgo sexual.

6.01.1.022 **Pitiriasis Rosada de Gilbert**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tiña corporis (KOH), sífilis secundaria y psoriasis en gotas.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P121 «Una mujer de 18 años presenta una placa eritematosa y levemente pruriginosa, de 5 cm, en la espalda, sin otros síntomas. Una semana después se…» →
Pitiriasis rosada

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 82** Tema 16.16

Clase 16.16 en video

71 TEMA 16.16 · MICOSIS Y ECTOPARÁSITOS

FOTO CLÍNICA

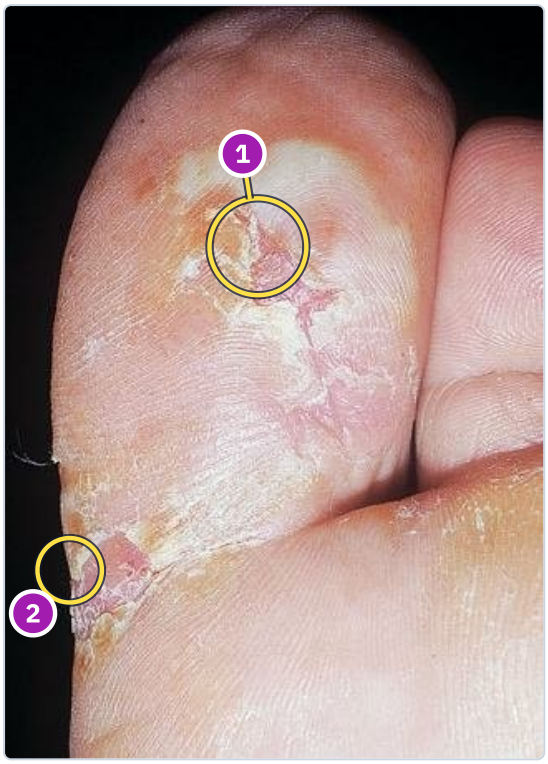


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Maceración y descamación
2. Fisura descamativa

DIAGNÓSTICO

Tiña pedis interdigital

«Pie de atleta»: maceración y fisuras interdigitales (4.º espacio).

CONDUCTA INICIAL

Terbinafina tópica 2–3 semanas; KOH si hay duda.

6.01.1.018 **Micosis superficiales**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Onicomicosis asociada: se confirma con KOH antes del tratamiento oral.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P44 «Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza…» → **Terbinafina**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 83** Tema 16.16

Clase 16.16 en video

72 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick Dermatology, p. 1093

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placas pardas «pegadas» sobre la piel
2. Múltiples en la cara

DIAGNÓSTICO

Queratosis seborreicas

Placas verrugosas «pegadas», café a negro, del adulto mayor; no malignizan.

CONDUCTA INICIAL

Observar; crioterapia si molestan; biopsia si cambian o hay duda con melanoma.

6.01.1.028 **Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Melanoma (ante la duda, biopsia); muchas de golpe con prurito = Leser-Trélat.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 88** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

73 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA

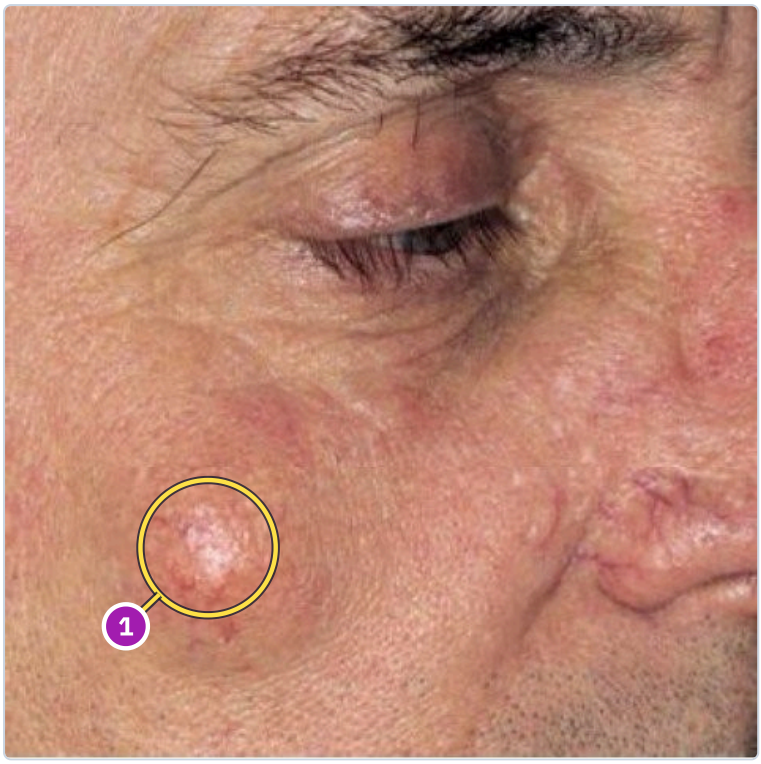


Imagen: Fitzpatrick Dermatology, p. 1102

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulo firme en la mejilla
2. Punctum central: lo distingue del quiste pilar

DIAGNÓSTICO

Quiste epidérmico

Nódulo firme y móvil con punctum central y contenido caseoso de queratina.

CONDUCTA INICIAL

Extirpar la pared completa fuera de la fase inflamatoria (4–6 semanas después).

6.01.1.028 **Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Quiste pilar (liso, sin punctum, cuero cabelludo) y lipoma (blando).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 88** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

74 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick Dermatology, Fig. 129-1

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulo subcutáneo blando en el antebrazo
2. Otro nódulo en el brazo contralateral

DIAGNÓSTICO

Lipomas múltiples

Nódulos subcutáneos blandos, lobulados, móviles e indoloros.

CONDUCTA INICIAL

Observar o extirpar; si mide más de 5 cm, es profundo o doloroso: RM y biopsia.

6.01.1.028 **Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Liposarcoma: más de 5 cm, profundo, firme, fijo, doloroso o de crecimiento rápido.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 88** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

75 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick Dermatology, Fig. 64-7A

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pápula firme pardo-rosada
   - Al comprimirla lateralmente se deprime: signo del hoyuelo

DIAGNÓSTICO

Dermatofibroma

Pápula firme pardo-rosada de 0,5–1 cm en las piernas de mujeres jóvenes.

CONDUCTA INICIAL

Benigno y asintomático: se extirpa solo si hay duda o molestia.

6.01.1.028 **Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Lesión pigmentada dudosa: ante la duda se extirpa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 90** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

76 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA

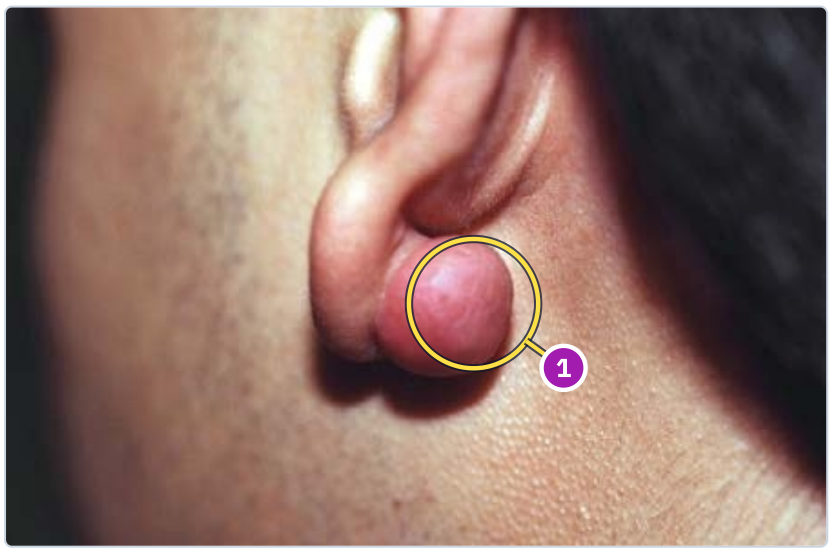


Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 700.1

QUÉ TIENES QUE VER

1. Tumor firme que sobrepasa la perforación del arete

DIAGNÓSTICO

Queloide del lóbulo

Sobrepasa los bordes de la herida, aparece meses después y no regresa.

CONDUCTA INICIAL

Triamcinolona intralesional (10–40 mg/mL cada 4–6 semanas) y silicona.

6.01.1.028 **Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Cicatriz hipertrófica: respeta los bordes y regresa en 1–2 años.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P64** «Un paciente, de 17 años, consulta por aparición de un nódulo blanquecino, que apareció hace 3 semanas, en una zona donde se había puesto un arete…» → **Queloide**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 88** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

77 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 691.8A

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa rojo brillante «en fresa»

DIAGNÓSTICO

Hemangioma infantil superficial

Placa rojo brillante «en fresa»: aparece semanas tras nacer, crece 3–5 meses e involuciona.

CONDUCTA INICIAL

La mayoría se observa (fotos seriadas); propranolol si hay riesgo funcional, ulceración o desfiguración.

6.01.1.013 **Hemangiomas cutáneos infantiles**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mancha en vino de Oporto: plana, presente al nacer, no involuciona.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P90** «Un niño de 7 meses nació con una mácula eritematosa, de tres cm, en la mano izquierda, la que ha ido creciendo en tamaño y espesor. Actualmente…» → **Observar evolución**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 90** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

78 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA

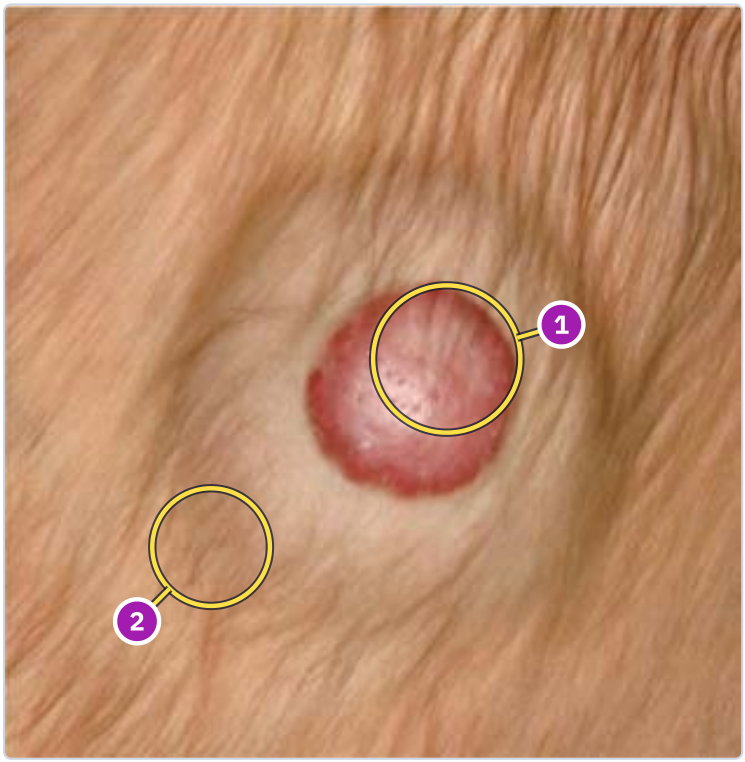


Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 691.8C

QUÉ TIENES QUE VER

1. Componente superficial rojo
2. Componente profundo: abombamiento bajo piel normal

DIAGNÓSTICO

Hemangioma infantil mixto

Combina un componente superficial rojo y uno profundo azulado bajo piel normal.

CONDUCTA INICIAL

Cinco o más hemangiomas: ecografía abdominal (compromiso hepático).

6.01.1.013 **Hemangiomas cutáneos infantiles**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Malformación venosa: masa azulada compresible que crece con el niño.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P126** «Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más…» → **Solicitar ecografía abdominal**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 88** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

79 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 691.12

QUÉ TIENES QUE VER

1. Hemangioma en el párpado superior
2. Componente segmentario en frente y sien

DIAGNÓSTICO

Hemangioma periocular

Puede causar ambliopía y astigmatismo: indicación de propranolol.

CONDUCTA INICIAL

Propranolol oral 2–3 mg/kg/día (partir con 1) y derivar; controlar FC, PA y glicemia.

6.01.1.013 Hemangiomas cutáneos infantiles — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Malformación capilar: plana y presente al nacer.

PREGUNTA REAL — **Agosto 2021 · P83** «Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente la visión. ¿Cuál es la…» → **Administrar propanolol**

TOMO DERMATOLOGÍA p. 102 Tema 16.17

Clase 16.17 en video

80 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA

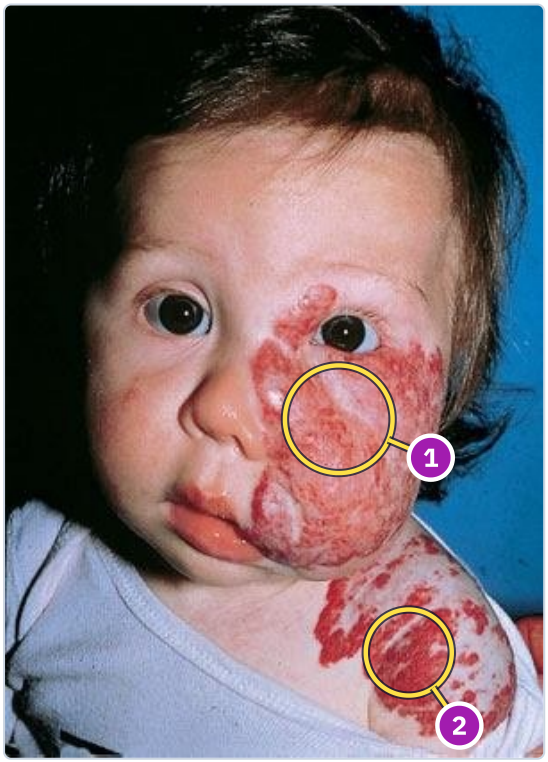


Imagen: Fitzpatrick Dermatology, p. 1203

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa roja lobulada en la hemicara
2. Se extiende al cuello y al hombro

DIAGNÓSTICO

Hemangioma infantil segmentario

Sigue un territorio de desarrollo: más complicaciones y asociación a síndromes (PHACE).

CONDUCTA INICIAL

Segmentario facial grande: RM, angio-RM y ecocardiograma; propranolol y derivar.

6.01.1.013 Hemangiomas cutáneos infantiles — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mancha en vino de Oporto: presente al nacer, plana, no involuciona.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA p. 88 Tema 16.17

Clase 16.17 en video

81 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 40.42

QUÉ TIENES QUE VER

1. Mácula rosada mal delimitada en la nuca

DIAGNÓSTICO

Mancha salmón (nevus simplex)

Mácula rosada mal delimitada en el 40–70% de los recién nacidos; en la nuca puede persistir.

CONDUCTA INICIAL

Tranquilizar: sin estudio ni tratamiento.

2.01.1.111 Malformaciones vasculares cutáneas
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mancha en vino de Oporto: bien delimitada, unilateral, se oscurece.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 88** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

82 TEMA 16.17 · TUMORES BENIGNOS Y VASCULARES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 1694

QUÉ TIENES QUE VER

1. Mácula roja bien delimitada, unilateral
2. Mejilla y cuello

DIAGNÓSTICO

Malformación capilar (mancha en vino de Oporto)

Presente al nacer, bien delimitada y unilateral; no desaparece y se oscurece con los años.

CONDUCTA INICIAL

Láser de colorante pulsado (derivar); si compromete V1, descartar Sturge-Weber.

2.01.1.111 Malformaciones vasculares cutáneas
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemangioma infantil: no está al nacer, crece y luego involuciona.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 88** Tema 16.17

Clase 16.17 en video

83 TEMA 16.18 · LOXOSCELISMO

OTRA (AGENTE O VECTOR)



Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 768.4

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cefalotórax con la marca en violín
2. Patas largas y finas

DIAGNÓSTICO

Araña de rincón (Loxosceles laeta)

Pardo amarillenta, 8–15 mm, patas largas y finas, con un violín en el cefalotórax.

CONDUCTA INICIAL

Capturarla con un vaso (no con la mano) y llevarla para identificarla; consultar de inmediato.

6.01.2.008 **Loxocelismo**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

6.01.3.002 **Higiene de la vivienda y profilaxis del loxoscelismo**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

La lesión se confunde con pioderma gangrenoso, ectima, fasceítis, celulitis y herpes zóster.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P149** «Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más probable?» → **Loxosceles laeta (araña de rincón)**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 92** Tema 16.18

Clase 16.18 en video

84 TEMA 16.18 · LOXOSCELISMO

FOTO CLÍNICA

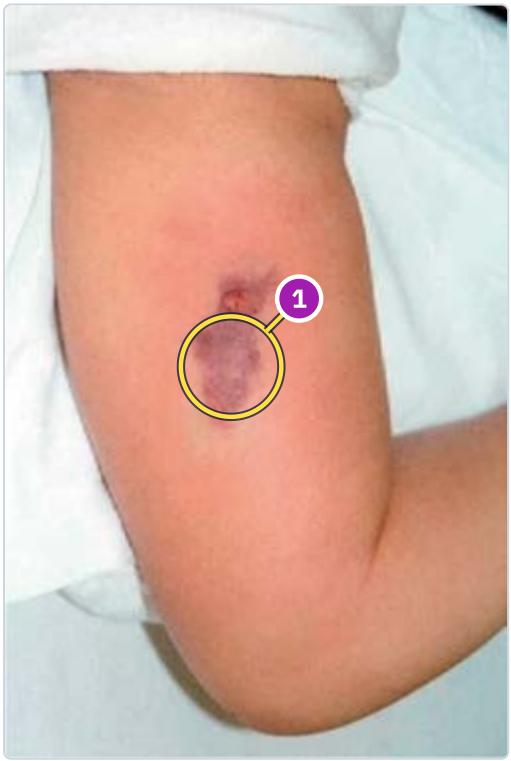


Imagen: Nelson 22.ª ed., cap. 768 (p. 4471)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Placa violácea de bordes geográficos

DIAGNÓSTICO

Loxoscelismo cutáneo: placa livedoide

A las 6–12 h: placa de bordes geográficos roja, violácea y pálida, a veces con ampolla hemorrágica.

CONDUCTA INICIAL

Reposo, elevación, frío local (no calor), analgesia y profilaxis antitetánica; control diario 48–72 h.

6.01.2.008 **Loxocelismo**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Celulitis, ectima, fasceítis necrotizante y herpes zóster.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P89** «Una paciente consulta por aparición de una lesión en el atebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se…» → **Loxsocelismo cutáneo**

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 92** Tema 16.18

Clase 16.18 en video

85 TEMA 16.18 · LOXOSCELISMO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 798

QUÉ TIENES QUE VER

1. Escara negra seca
2. Bordes geográficos violáceos

DIAGNÓSTICO

Loxoscelismo: escara negra

En 24–72 h se extiende por gravedad y evoluciona a escara negra seca, que demarca en 7–14 días.

CONDUCTA INICIAL

Debridar la escara tardíamente (2–4 semanas), cuando está demarcada; nunca escisión precoz.

6.01.2.008 Loxocelismo

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Pioderma gangrenoso, ectima y fasceítis necrotizante.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 92** Tema 16.18

Clase 16.18 en video

86 TEMA 16.18 · LOXOSCELISMO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson 22.ª ed., cap. 768 (p. 4471)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Úlcera de fondo fibrinoso y bordes netos

DIAGNÓSTICO

Loxoscelismo: úlcera de fondo fibrinoso

Al desprenderse la escara queda una úlcera de cicatrización lenta (semanas a meses).

CONDUCTA INICIAL

Manejo como herida crónica, con eventual injerto.

6.01.2.008 Loxocelismo

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Pioderma gangrenoso: úlcera de borde violáceo y socavado (EII, AR).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO DERMATOLOGÍA **p. 92** Tema 16.18

Clase 16.18 en video

Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Melanoma vs nevo común



VS



A Melanoma: regla ABCDE

- Asimétrico, bordes irregulares
- Varios colores; > 6 mm o en evolución

Ficha n.° 55 · p. 32

B Nevo melanocítico común

- Simétrico, borde regular
- Color homogéneo, < 6 mm, estable

Ficha n.° 53 · p. 31

LA DIFERENCIA La E (evolución) es el criterio más sensible: cualquier cambio obliga a biopsia excisional.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Psoriasis vs eccema atópico



VS



A Psoriasis en placas

- Placa bien delimitada, escama nacarada
- Superficies de extensión

Ficha n.° 18 · p. 13

B Dermatitis atópica: eccema con rascado

- Eccema con xerosis y rascado
- Prurito intenso; pliegues flexurales

Ficha n.° 26 · p. 17

LA DIFERENCIA Psoriasis: Auspitz y Koebner. Atopia: sin prurito intenso no hay dermatitis atópica.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Pénfigo vulgar vs penfigoide ampollar



VS



A Pénfigo vulgar

- Ampollas flácidas que se rompen: erosiones
- Nikolsky positivo; boca en 70–90%

Ficha n.° 44 · p. 26

B Penfigoide ampollar

- Ampollas tensas que resisten días
- Nikolsky negativo; ancianos con prurito

Ficha n.° 45 · p. 27

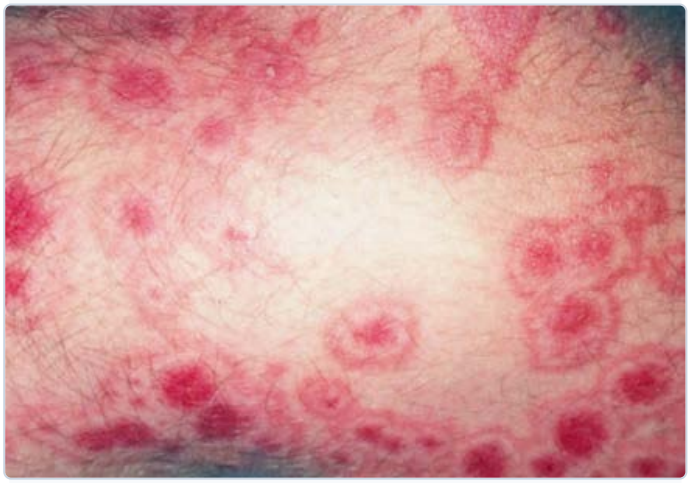
LA DIFERENCIA Intraepidérmica (desmogleína) vs subepidérmica (BP180/BP230): IFD en red vs lineal.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Eritema multiforme vs Stevens-Johnson



VS



A Eritema multiforme

- Diana típica de 3 anillos
- Acral; tras un herpes simple

Ficha n.° 47 · p. 28

B Stevens-Johnson: dianas atípicas

- Diana atípica de 2 anillos, centro purpúrico
- Tronco; tras un fármaco

Ficha n.° 34 · p. 21

LA DIFERENCIA Cuenta los anillos y busca el Nikolsky: negativo en el eritema multiforme, positivo en el SSJ.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Necrólisis epidérmica tóxica vs piel escaldada



VS



A Necrólisis epidérmica tóxica

- Desprendimiento en sábanas > 30%
- Mucosas comprometidas; fármaco

Ficha n.° 36 · p. 22

B Síndrome de piel escaldada estafilocócica

- Erosiones superficiales «escaldadas»
- Mucosas respetadas; niño < 6 años

Ficha n.° 38 · p. 23

LA DIFERENCIA Ambas tienen Nikolsky positivo: las mucosas deciden. La piel escaldada cura en 5–7 días sin cicatriz.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Carcinoma basocelular vs espinocelular



VS



A Carcinoma basocelular nodular

- Pápula perlada con telangiectasias
- Metástasis < 0,01%

Ficha n.° 57 · p. 33

B Carcinoma espinocelular

- Placa o nódulo queratósico costroso
- Sobre queratosis actínica; 2–5% metastiza

Ficha n.° 59 · p. 34

LA DIFERENCIA Perlado vs costroso; el espinocelular se deriva con prioridad (labio y oreja: hasta 15–20%).

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Enfermedad de Bowen vs tiña corporis



VS



A Enfermedad de Bowen

- Placa eritematosa escamosa solitaria
- No cede con corticoides ni antifúngicos

Ficha n.° 64 · p. 36

B Tiña corporis

- Placa anular con borde activo
- Centro que aclara; KOH positivo

Ficha n.° 67 · p. 38

LA DIFERENCIA Toda placa solitaria que no responde al tratamiento se biopsia.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Pitiriasis rosada vs psoriasis en gotas



VS



A Pitiriasis rosada: placa heráldica

- Medallón oval con collarete
- Luego «árbol de Navidad» en la espalda

Ficha n.° 70 · p. 39

B Psoriasis en gotas

- Pápulas milimétricas «en gotas»
- 1–2 semanas tras faringoamigdalitis

Ficha n.° 19 · p. 13

LA DIFERENCIA Busca el medallón previo y pide VDRL si hay riesgo sexual (sífilis secundaria).

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hemangioma infantil vs malformación capilar



VS



A Hemangioma infantil superficial

- No está al nacer; crece 3–5 meses
- Luego involuciona; GLUT-1 positivo

Ficha n.° 77 · p. 43

B Malformación capilar (mancha en vino de Oporto)

- Presente al nacer, plana
- Nunca involuciona; GLUT-1 negativo

Ficha n.° 82 · p. 45

LA DIFERENCIA Un tumor que crece y se va vs una malformación que crece con el niño.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Alopecia areata vs tiña capitis



VS



A Alopecia areata

- Piel lisa, sin escama
- Pelos en signo de exclamación

Ficha n.° 16 · p. 12

B Tiña capitis

- Placa con escamas y pelos rotos
- Niños; KOH y lámpara de Wood

Ficha n.° 65 · p. 37

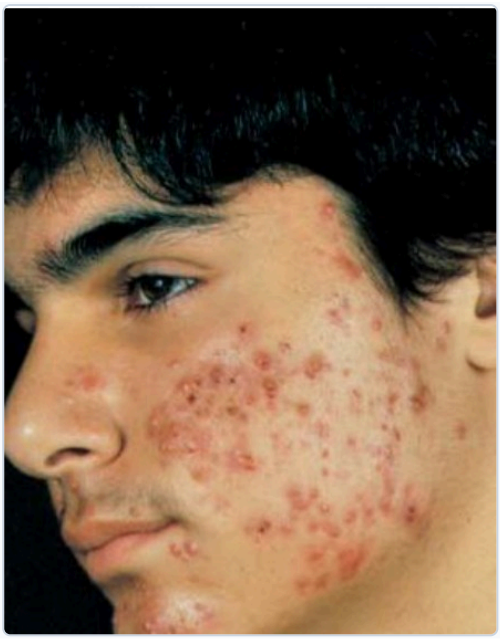
LA DIFERENCIA La tiña capitis se trata SIEMPRE por vía oral (griseofulvina o terbinafina).

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Rosácea vs acné



VS



A Rosácea pápulo-pustulosa

- Pápulas y pústulas sobre eritema
- SIN comedones; mujeres de 30–50 años

Ficha n.° 14 · p. 11

B Acné pápulo-pustuloso

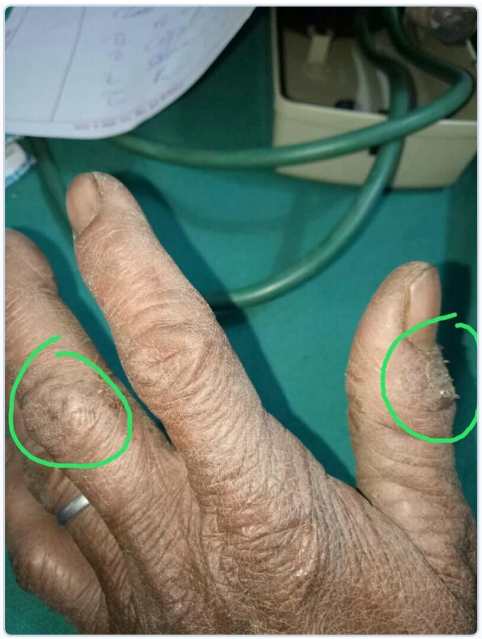
- Comedón + pápulas y pústulas
- Desde la pubertad (andrógenos)

Ficha n.° 12 · p. 10

LA DIFERENCIA Busca comedones antes de decidir: si los hay, es acné.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Contacto irritativa vs alérgica



VS



A Dermatitis de contacto irritativa

- Ardor, piel seca y fisurada
- Confinada al contacto; parche negativo

Ficha n.° 28 · p. 18

B Eccema de contacto alérgico

- Prurito intenso, vesículas
- Sobrepasa el contacto; parche positivo 48–96 h

Ficha n.° 29 · p. 18

LA DIFERENCIA Irritativa 80% (no inmune) vs alérgica 20% (tipo IV; el níquel es el alérgeno más frecuente).

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Urticaria vs púrpura palpable



VS



A Urticaria aguda

- Habón evanescente < 24 h
- Prurito; sin marca residual

Ficha n.º 32 · p. 20

B Púrpura palpable

- Púrpura: no desaparece a la vitropresión
- Vasculitis: buscar la causa

Ficha n.º 03 · p. 4

LA DIFERENCIA Habón fijo más de 24–48 h que deja púrpura = vasculitis urticariana: biopsia.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



SIGNO DE NIKOLSKY

La epidermis se despega con una fricción suave sobre piel eritematosa o perilesional.

Se ve en: SSJ/NET, pénfigo vulgar, piel escaldada (negativo en eritema multiforme y penfigoide).

Tomo p. 45 · Atlas: ficha n.° 38, p. 23

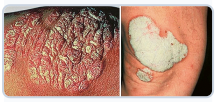
SIGNO DE ASBOE-HANSEN

sin foto en el atlas

Al comprimir verticalmente una ampolla, el líquido se extiende y despega la piel vecina.

Se ve en: Pénfigo vulgar, SSJ/NET.

Tomo p. 54



SIGNO DE AUSPITZ (ROCÍO SANGRANTE)

Al retirar la membrana del raspado de Brocq queda un punteado hemorrágico fino. Patognomónico.

Se ve en: Psoriasis.

Tomo p. 25 · Atlas: ficha n.° 18, p. 13

SIGNO DE LA BUJÍA (MANCHA DE CERA)

sin foto en el atlas

Al raspar la placa se desprenden virutas blanquecinas, como al raspar una vela.

Se ve en: Psoriasis (1.er paso del raspado de Brocq).

Tomo p. 25



FENÓMENO DE KOEBNER

Lesiones típicas que aparecen sobre piel sana traumatizada (herida, roce, rascado).

Se ve en: Psoriasis, líquen plano, vitíligo, verrugas planas.

Tomo p. 25 · Atlas: ficha n.° 21, p. 14

SIGNO DE DARIER

sin foto en el atlas

Habón al frotar una lesión.

Se ve en: Mastocitosis (citado en el solucionario como distractor).

Tomo p. 97



SIGNO DE HUTCHINSON (UÑA)

Pigmento que invade el pliegue ungueal cutáneo.

Se ve en: Melanoma lentiginoso acral.

Tomo p. 68 · Atlas: ficha n.° 56, p. 32

SIGNO DE HUTCHINSON (ZÓSTER)

sin foto en el atlas

Vesículas en la punta de la nariz: anuncian compromiso ocular.

Se ve en: Zóster oftálmico: derivar de urgencia a oftalmología.

Tomo p. 60



SIGNO DE LESER-TRÉLAT

Aparición brusca de muchas queratosis seborreicas con prurito.

Se ve en: Sugiere neoplasia interna, sobre todo digestiva.

Tomo p. 90 · Atlas: ficha n.° 72, p. 40



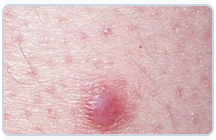
SIGNO DE LA UÑADA (BESNIER)

Descamación fina furfurácea al raspar la mácula.

Se ve en: Pitiriasis versicolor.

Tomo p. 84 · Atlas: ficha n.° 68, p. 38

Signos con nombre propio · continuación



SIGNO DEL HOYUELO

Al comprimir lateralmente la pápula, esta se deprime.

Se ve en: Dermatofibroma.

Tomo p. 101 · Atlas: ficha n.° 75, p. 42

PRUEBA DE TRACCIÓN (PULL TEST)

sin foto en el atlas

Positiva difusa: más de 10 pelos con bulbo al traccionar.

Se ve en: Efluvio telógeno.

Tomo p. 19



SIGNO DEL PATITO FEO

La lesión que no se parece a las demás del paciente.

Se ve en: Sospecha de melanoma.

Tomo p. 68 · Atlas: ficha n.° 61, p. 35



DIANA EN ESCARAPELA

Tres zonas concéntricas: centro oscuro, anillo pálido, halo rojo.

Se ve en: Eritema multiforme (la diana de 2 anillos es del SSJ).

Tomo p. 62 · Atlas: ficha n.° 47, p. 28



PELOS EN SIGNO DE EXCLAMACIÓN

Pelos cortos fracturados, más delgados en la base, en el borde de la placa.

Se ve en: Alopecia areata.

Tomo p. 19 · Atlas: ficha n.° 16, p. 12

ESTRÍAS DE WICKHAM

sin foto en el atlas

Fina red blanquecina sobre las pápulas violáceas.

Se ve en: Líquen plano.

Tomo p. 28



«ÁRBOL DE NAVIDAD»

Placas ovales cuyo eje sigue las líneas de Langer en la espalda.

Se ve en: Pitiriasis rosada (también: raya central ensanchada en la alopecia femenina).

Tomo p. 82 · Atlas: ficha n.° 70, p. 39

PÁPULAS DE GOTTRON Y HELIOTROPO

sin foto en el atlas

Pápulas en los nudillos y eritema violáceo palpebral.

Se ve en: Dermatomiositis: en adultos, buscar neoplasia.

Tomo p. 5

Índice por tipo de imagen

82	0	2	1	0	1
FOTO CLÍNICA	DERMATOSCOPÍA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	OTRA (AGENTE O VECTOR)

Foto clínica · 82

01 Mancha café con leche (16.1) 4
02 Eritema nudoso (16.1) 5
03 Púrpura palpable (16.1) 4
04 Vesículas de herpes simple (16.1) 6
05 Ampollas tensas (penfigoide) (16.1) 6
06 Habones (16.1) 7
07 Pústulas palmares (16.1) 7
08 Pápulas de molusco contagioso (16.1) 8
09 Liquenificación (16.1) 8
10 Úlcera con escara (16.1) 9
11 Acné comedoniano (16.2) 9
12 Acné pápulo-pustuloso (16.2) 10
13 Acné nódulo-quístico (16.2) 10
14 Rosácea pápulo-pustulosa (16.3) 11
15 Rinofima (rosácea fimatosa) (16.3) 11
16 Alopecia areata (16.4) 12
18 Psoriasis en placas (16.5) 13
19 Psoriasis en gotas (16.5) 13
20 Pitting ungueal (16.5) 14
21 Fenómeno de Koebner (16.5) 14
22 Artritis psoriásica (16.5) 15
23 Psoriasis pustulosa generalizada (16.5) 15
24 Líquen plano oral erosivo (16.5) 16
25 Eccema herpético de Kaposi (16.6) 16
26 Dermatitis atópica: eccema con rascado (16.6) 17
27 Impetiginización de la dermatitis atópica (16.6) 17
28 Dermatitis de contacto irritativa (16.7) 18
29 Eccema de contacto alérgico (16.7) 18
30 Dermatitis seborreica del adulto (16.7) 19
31 Fototoxicidad (16.7) 19
32 Urticaria aguda (16.8) 20
33 Angioedema labial (16.8) 20
34 Stevens-Johnson: dianas atípicas (16.9) 21
35 Necrólisis epidérmica: mucosas (16.9) 21
36 Necrólisis epidérmica tóxica (16.9) 22
37 Stevens-Johnson: labios (16.9) 22
38 Síndrome de piel escaldada estafilocócica (16.9) 23
39 Exantema morbiliforme (maculopapular) (16.10) 23
40 DRESS: exantema del tronco (16.10) 24
41 DRESS: edema facial (16.10) 24
42 Toxidermia fija (16.10) 25
44 Pénfigo vulgar (16.11) 26
45 Penfigoide ampollar (16.11) 27
46 Pénfigo vulgar oral (16.11) 26
47 Eritema multiforme (16.12) 28
48 Eritema multiforme: dianas en las manos (16.12) 28
49 Molusco contagioso (16.12) 29
51 Herpes zóster diseminado (16.12) 30
52 Verruga vulgar (16.12) 30
53 Nevo melanocítico común (16.13) 31
54 Melanoma nodular (16.13) 31
55 Melanoma: regla ABCDE (16.13) 32
56 Melanoma lentiginoso acral subungueal (16.13) 32
57 Carcinoma basocelular nodular (16.14) 33
58 Úlcera de Rodent (CBC ulcerado) (16.14) 33
59 Carcinoma espinocelular (16.14) 34
60 Carcinoma espinocelular del labio (16.14) 34
61 Nevos displásicos (atípicos) (16.15) 35
62 Cuerno cutáneo (16.15) 35
63 Queratosis actínica (16.15) 36
64 Enfermedad de Bowen (16.15) 36
65 Tiña capitis (16.16) 37
66 Tiña inguinal (cruris) (16.16) 37
67 Tiña corporis (16.16) 38
68 Pitiriasis versicolor (16.16) 38
69 Escabiosis (16.16) 39
70 Pitiriasis rosada: placa heráldica (16.16) 39
71 Tiña pedis interdigital (16.16) 40
72 Queratosis seborreicas (16.17) 40
73 Quiste epidérmico (16.17) 41
74 Lipomas múltiples (16.17) 41
75 Dermatofibroma (16.17) 42
76 Queloide del lóbulo (16.17) 42
77 Hemangioma infantil superficial (16.17) 43
78 Hemangioma infantil mixto (16.17) 43
79 Hemangioma periocular (16.17) 44
80 Hemangioma infantil segmentario (16.17) 44
81 Mancha salmón (nevus simplex) (16.17) 45
82 Malformación capilar (mancha en vino de Oporto) (16.17) 45
84 Loxoscelismo cutáneo: placa livedoide (16.18) 46
85 Loxoscelismo: escara negra (16.18) 47
86 Loxoscelismo: úlcera de fondo fibrinoso (16.18) 47

Dermatoscopía · 0

Sin imágenes de dermatoscopía en las fuentes de este tomo; los patrones se describen en el Tomo, p. 71.

Histología / citología · 2

43 IFD de pénfigo vulgar (16.11) 25
50 Test de Tzanck: célula gigante multinucleada (16.12) 29

Esquema · 1

17 Alopecia androgenética: escala de Hamilton-Norwood (16.4) 12

Imagen radiológica · 0

Sin imágenes de este tipo en las fuentes.

Otra (agente o vector) · 1

83 Araña de rincón (Loxosceles laeta) (16.18) 46

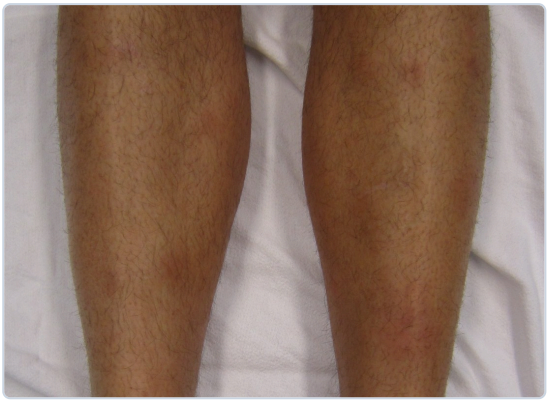
Autoevaluación

53 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



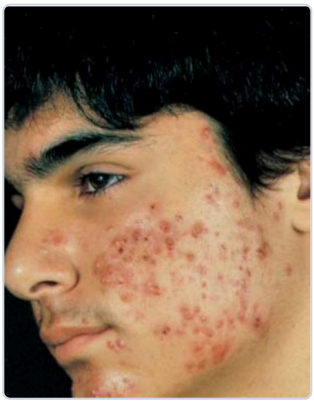
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



8 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



9 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



10 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



11 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



12 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



13 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



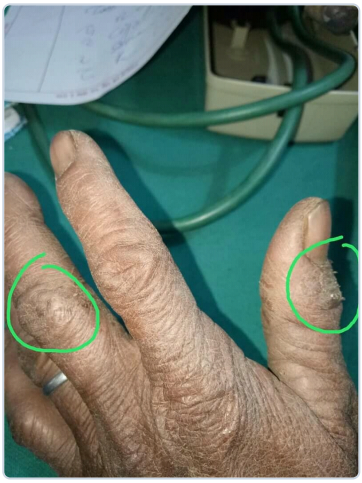
14 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



15 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



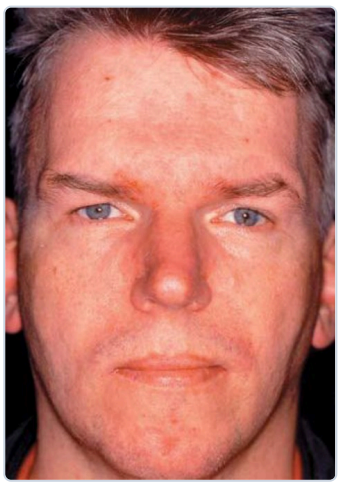
16 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



17 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



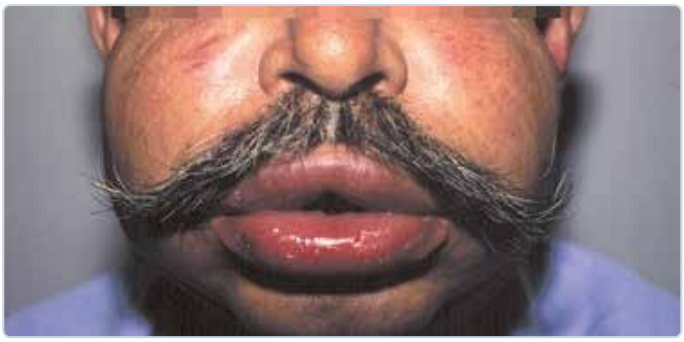
18 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



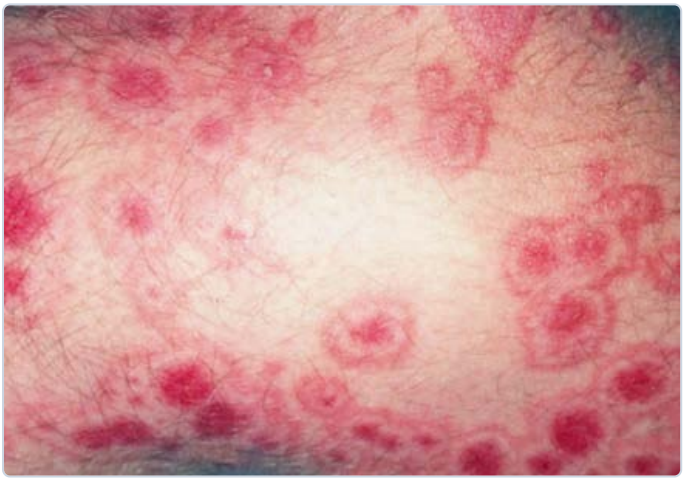
19 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



20 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



21 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



22 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



23 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



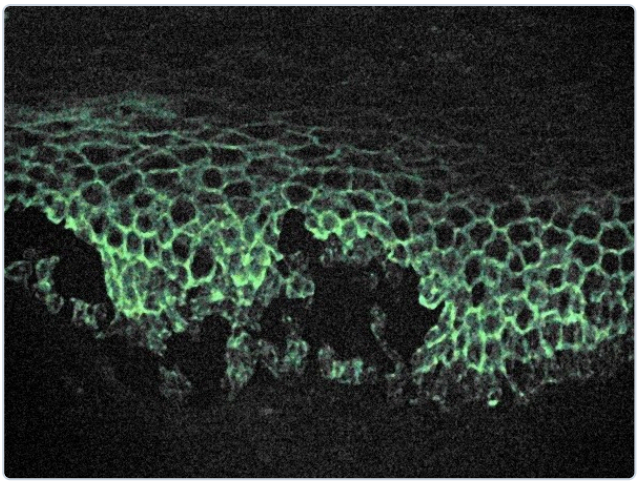
24 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



25 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



26 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



27 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



28 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



29 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



30 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



31 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



32 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



33 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



34 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



35 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



36 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



37 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



38 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



39 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



40 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



41 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



42 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



43 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



44 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



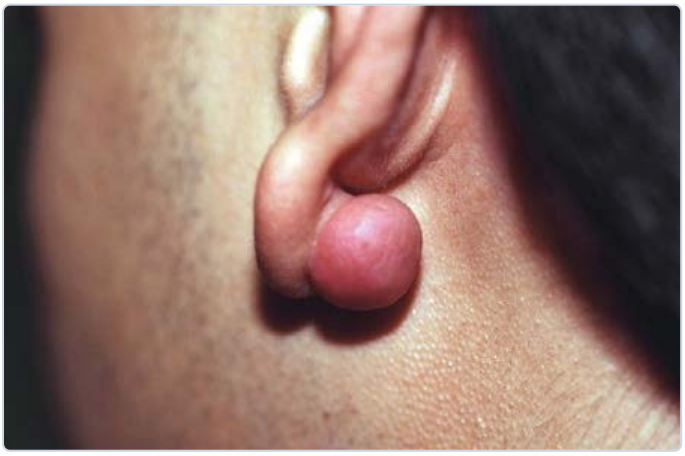
45 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



46 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



47 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



48 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



49 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



50 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



51 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



52 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



53 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Mancha café con leche**	Lesión plana: cambio de color sin relieve ni depresión	01 · p. 4
2	**Eritema nudoso**	Nódulos eritematosos mal delimitados en la cara anterior de la pierna	02 · p. 5
3	**Vesículas de herpes simple**	Vesícula: contenido líquido, menor de 0,5 cm	04 · p. 6
4	**Pápulas de molusco contagioso**	Pápula sólida, menor de 1 cm	08 · p. 8
5	**Úlcera con escara**	Escara negra y seca	10 · p. 9
6	**Acné pápulo-pustuloso**	Pápulas eritematosas inflamatorias	12 · p. 10
7	**Acné nódulo-quístico**	Nódulos profundos inflamatorios	13 · p. 10
8	**Rosácea pápulo-pustulosa**	Pápulas y pústulas en la mejilla	14 · p. 11
9	**Alopecia areata**	Piel lisa, sin escama ni eritema	16 · p. 12
10	**Psoriasis en placas**	Escamas gruesas blanco-nacaradas, no grasosas	18 · p. 13
11	**Fenómeno de Koebner**	Placas alineadas sobre una cicatriz	21 · p. 14
12	**Artritis psoriásica**	Interfalángica distal comprometida	22 · p. 15
13	**Psoriasis pustulosa generalizada**	Pústulas estériles agrupadas	23 · p. 15
14	**Eccema herpético de Kaposi**	Erosiones «en sacabocado» agrupadas	25 · p. 16
15	**Dermatitis atópica: eccema con rascado**	Placa eritematosa con descamación	26 · p. 17
16	**Dermatitis de contacto irritativa**	Piel seca, agrietada y fisurada	28 · p. 18
17	**Eccema de contacto alérgico**	Eccema descamativo en el dorso de la mano	29 · p. 18
18	**Dermatitis seborreica del adulto**	Entrecejo y cejas	30 · p. 19
19	**Urticaria aguda**	Habones sobreelevados, rosados	32 · p. 20
20	**Angioedema labial**	Labio inferior tumefacto, tenso y deformado	33 · p. 20
21	**Stevens-Johnson: dianas atípicas**	Diana atípica: centro purpúrico y 2 anillos	34 · p. 21
22	**Necrólisis epidérmica tóxica**	Dermis roja denudada en la espalda	36 · p. 22
23	**Síndrome de piel escaldada estafilocócica**	Erosiones húmedas «escaldadas»	38 · p. 23
24	**DRESS: edema facial**	Edema malar prominente con lesiones	41 · p. 24
25	**Toxidermia fija**	Placa violácea redonda, bien delimitada	42 · p. 25
26	**IFD de pénfigo vulgar**	Patrón en red de pescar (panal de abejas)	43 · p. 25
27	**Pénfigo vulgar**	Erosiones costrosas: ampollas flácidas rotas	44 · p. 26

Soluciones · continuación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
28	**Penfigoide ampollar**	Ampolla tensa de contenido seroso	45 · p. 27
29	**Eritema multiforme**	Diana: centro oscuro, anillo pálido, halo rojo	47 · p. 28
30	**Molusco contagioso**	Pápula perlada umbilicada	49 · p. 29
31	**Nevo melanocítico común**	Simétrico, borde regular, color homogéneo	53 · p. 31
32	**Melanoma: regla ABCDE**	Asimetría y bordes irregulares	55 · p. 32
33	**Melanoma lentiginoso acral subungueal**	Pigmento que invade el pliegue ungueal (signo de Hutchinson)	56 · p. 32
34	**Carcinoma basocelular nodular**	Aspecto perlado, translúcido y brillante	57 · p. 33
35	**Carcinoma espinocelular**	Nódulo con costra hiperqueratósica central	59 · p. 34
36	**Cuerno cutáneo**	Protrusión cónica hiperqueratósica compacta	62 · p. 35
37	**Queratosis actínica**	Mácula eritematosa con escama adherente	63 · p. 36
38	**Enfermedad de Bowen**	Placa eritematosa, escamosa, bien delimitada	64 · p. 36
39	**Tiña capitis**	Placa alopécica descamativa en la nuca	65 · p. 37
40	**Tiña inguinal (cruris)**	Borde activo eritematoso y bien definido	66 · p. 37
41	**Tiña corporis**	Borde activo solevantado y descamativo	67 · p. 38
42	**Pitiriasis versicolor**	Máculas hipopigmentadas confluentes	68 · p. 38
43	**Escabiosis**	Lesiones excoriadas en la palma	69 · p. 39
44	**Pitiriasis rosada: placa heráldica**	Placa oval rosada (medallón)	70 · p. 39
45	**Queratosis seborreicas**	Placas pardas «pegadas» sobre la piel	72 · p. 40
46	**Quiste epidérmico**	Nódulo firme en la mejilla	73 · p. 41
47	**Queloide del lóbulo**	Tumor firme que sobrepasa la perforación del arete	76 · p. 42
48	**Hemangioma infantil superficial**	Placa rojo brillante «en fresa»	77 · p. 43
49	**Hemangioma periocular**	Hemangioma en el párpado superior	79 · p. 44
50	**Hemangioma infantil segmentario**	Placa roja lobulada en la hemicara	80 · p. 44
51	**Malformación capilar (mancha en vino de Oporto)**	Mácula roja bien delimitada, unilateral	82 · p. 45
52	**Loxoscelismo cutáneo: placa livedoide**	Placa violácea de bordes geográficos	84 · p. 46
53	**Loxoscelismo: escara negra**	Escara negra seca	85 · p. 47